010

019

۱۱۰ ۳۴

4G Vo)

D

Q

1_3784066676

فصل اول

۱۵:۱۳

>

شناخت اختلالهای هیجانی و رفتاری

اختلالات ،هدف کلی آشنایی با اختلالات رفتاری و هیجانی و انواع اختلالات هیجانی

کنترل تکانه و سلوک

هدفهای یادگیری

تفاوت بین بهنجاری و نابهنجاری را .۱ :از دانشجویان انتظار میرود پس از مطالعه و یادگیری محتوای این فصل بتوانند توضیح دهند.

انواع اختلالات هیجانی را نام برده هر کدام را به .اختلالات رفتاری یا هیجانی را از دیدگاه های مختلف توضیح دهند .۲ کنترل تکانه و سلوک را توضیح دهند ،اختلالات مخرب .صورت مختصر توضیح دهند.

۵. اختلال اضطراب جدایی را توضیح دهند.

و انواع اختلالات دفع را نام برده و هر کدام را توضیح دهند.

مقدمه

محمد تازه از تربیت معلم فارغ التحصیل شده بود و در یک روستای دور مشغول به .بحث را با یک کیس آغاز میکنیم خل وضع است و بچه ها مسخره اش »ابتدای ورود به روستا پدر یکی از بچه ها آمد سراغش و گفت که پسرم .تدریس شد

دوست ندارم در کوچه ها ول بشود و دیگران مسخره اش کنند انتظار هم ندارم شما چیزی به او .می کنند

%P. 4G Vos)

IT LTE1

:

Q

B

1_3784066676

اختلال های رفتاری و هیجانی

۱۵:۱۴

T

عقلی تعادل روانی و سازگاری ،ترتیب اگر فردی رفتارهای مورد تأثیر جامعه را از خود بروز ندهد یا از لحاظ تواناییهای

(۱۳۹۶)نابهنجار تلقی میشود باچر و همکاران .اجتماعی از معیارهای رایج و عمومی باشد

علی رغم مطالب فوق الذکر نمیتوان بین افراد بهنجار و نابهنجار خط فاصل مشخص و معینی را ترسیم کرد در مورد آن عده از رفتارهای نابهنجار که با رفتارهای معمولی و رایج تفاوتهای آشکاری دارند و در نظر اول به چشم می آیند مشکلی اوتستیک است یا ،با دیگران در جنگ و ستیز است یا نمیتواند صحبت کند ًکودکی که دائما ًبرای تشخیص وجود ندارد مثلا دزدیهای آشکار دارد و بیش از حد دروغ می گوید نابهنجار است؛ ولی اظهار نظر و قضاوت در مورد رفتارهای نابهنجاری که شواهد ظاهری و آشکاری ندارند و انحراف آنها از معیار اندک است بسیار مشکل

.خواهد بود

مسئله اساسی دیگری که باید متذکر شد این است که انواع رفتارهای مختلف در کلیه افراد بشری مشاهده میشود و آنچه تفاوت بین رفتار بهنجار و نابهنجار را مشخص میکند از لحاظ درجه رفتار است نه نوع رفتار؛ یعنی رفتار افراد نابهنجار همان رفتار افراد بهنجار است منتهی در حد اغراق آمیز و افراطی به طور مثال همه مردم از مکانیسم های دفاعی استفاده حتی غیر واقع بینانه عمل میکنند یا از تواناییهای ذهنی عاطفی و اجماعی خویش استفاده ،میکنند بعضی مواقع اشتباه میکنند کامل را نمی برند تمام این رفتارها در حد معقول بهنجار تلقی میشود ولی تکرار بیش از اندازه آنها نابهنجار قلمداد میشود

سلیگمن و روزنهان، ۱۳۹۶).

چنانچه ملاحظه شد تشخیص رفتار بهنجار از نابهنجار عمل آسانی نیست و توصیه میشود در مواردی که شدت رفتار در نباید .یا به عبارت دیگر به مفهوم دقیق کلمه نابهنجار نیستند ،حدی نیست که بتوان کلمه نابهنجار را در مورد آن بکار برد به آنان برچسب نابهنجاری بزنند و در چنین مواقعی بهتر است از آنها به عنوان افرادی که دارای مشکلات هیجانی و رفتاری هستند یاد کنیم.

۱ شناسایی رفتار بهنجار-۱

برای بیشتر کودکان در آشفتگی و پریشانی –دوست یابی و یادگیری ،زمانی برای بازی :کودکی باید دورانی شاد باشد

مداوم

کودکان این گونه است؛ اما زندگی

>XP. 40 Vos)

AT LTE1

D

Q

B

■. Developmental Disability

1_3784066676

۱۵:۱۴

شناخت اختلالهای هیجانی و رفتاری

وی کودکی ۱۱ یا ۱۲ .یکی از نخستین تلاشهای مستند در زمینه کودکان دارای نیازهای ویژه توسط ایتارد صورت گرفت را که توسط شکارچیان پیدا شده بود مورد آموزش قرارداد ویکتور در ابتدا لال بود روی چهار دست «ویکتور»ساله به نام و پا راه میرفت به حالت درازکش روی زمین آب میخورد و دائم بدن خود را می خاراند و شایع شده بود که توسط حیوانات ،پس از پنج سال کار بر روی ویکتور .اینارد معتقد بود با آموزش میتوان او را به حالت نرمال برگرداند .پرورش یافته است .کند معنای برخی کلمه ها را بفهمد و برخی از اشیا بیا بخشی هایی از آن را نام ببرد،وی میتوانست اشیا را شناسایی

ماش)اغلب اوقات ما را نسبت به رفتار دیگران و شیوه های توصیف این رفتارها حساس تر میکند ،مطالعه رفتار نابهنجار وسط معتدل و معمولی اطلاق میشود و نابهنجار آنچه را که ،معدل حد ،۲۰۱۹ کلمه بهنجار از نظر لغوی به مفهوم)و ولف اعتدال و معمولی منحرف باشد را در ذهن تداعی میکند البته در اینجا آن جنبه از انحراف که در جهت منفی ،از حد وسط است مورد نظر ما است.

برای آنکه ما بتوانیم رفتار نابهنجار را تشخیص دهیم باید بتوانیم رفتار بهنجار را تعریف کنیم و مشخص نماییم که آیا رفتار ارائه تعریفی از رفتار بهنجار که جامع باشد امری مشکل است زیرا .مورد نظر با رفتار بهنجار تفاوت دارد یا ندارد گوناگونی و گستردگی رفتارها و پاسخهای هر یک از افراد بشری از یک سو و تفاوتهای عوامل ژنتیکی و محیطی که نقش مهمی در ساخت رفتار افراد دارند از سوی دیگر به ویژه تفاوت های فاحشی که در آداب ورسوم و سنن جوامع مختلف و به طور کلی فرهنگهای متفاوت

تعریف دیگری که با توجه به همین .(۱۳۹۶ ،باچر مینکا و هولی)وجود دارد بیان تعریف کاملی را غیر ممکن میسازد ملاک میتوان بیان داشت این است که اصطلاح بهنجار در مورد آن عده از افراد جامعه بکار میرود که از لحاظ توانایی های بدین .تعادل روانی و سازگاری اجتماعی در حد معیارهای رایج در جامعه باشند ،عقلی

1. Children With Special Needs

2. Itard

3. Abnormal

4. Mash

5. Wolfe

6. Normal 7. Butcher 8. Mineka 9. Hooley

>:.

۱۱۸%

Q

4G Vol)

1_3784066676

۱۵:۱۳

>

Y

اختلالهای رفتاری و هیجانی

محمد پذیرفت و با مهربانی با او برخورد می کرد؛ ،بنا به توصیه پدر آن بچه .فقط میخواهم در کلاس شما باشد .یاد بدهید میدهیم نظم کلاس را به هم میریخت روی نیمکتها راه میرفت؛ از پنجره کلاس «کاوه»اما آن پسربچه که ما به او نام میرفت بیرون از میله پرچمی که کنار پنجره بود بالا میرفت و حسابی نظم کلاس را به هم میریخت و محمد هم علی رغم قولی که به پدر کاوه داده بود گاهی ناچار می شد که او را تنبیه کند محمد می گفت یک روز که زنگ تفریح بود و خودم در مینوشت تعجب کردم و ،حیاط قدم میزدم میدیدم هر چه بچه های دیگر میگفتند کاوه هجی میکرد و کف زمین که خاکی بود از .از آن روز به بعد باهاش مهربان تر بودم و او را آزادتر می گذاشتم .پیش خودم گفتم این بچه نباید عقب مانده ذهنی باشد خود این سؤالها را بپرسید آیا رفتار کاوه نابهنجار به نظر می آید یا اینکه جنبه هایی از رفتار بهنجار او تحت شرایط محیطی خاصی است؟ شما مشکلات کاوه را چگونه توصیف میکنید؟ آیا مشکل او مشکل هیجانی است؟ مشکلی رفتاری است؟ یا یک نارسایی تحولی؟

(۱۸۳۸-۱۷۷۴)۱ ژان مارک کاسپر ایتارد و ویکتور -شکل ۱

1. Developmental Disability

|||

>:

<>

۱۱۰ ۱۳۴

1_3784066676

۱۵:۱۴

>

شناخت اختلالهای هیجانی و رفتاری

در هر زمینه ای غیر قابل قبول هستند؛ اما قابل قبول بودن بسیاری از رفتارهای دیگر نیز به نگرش بیننده وابسته است (ماش و ولف ۲۰۱۹)

اختلال های هیجانی یا رفتاری به شرایطی گفته میشود که در آن پاسخهای رفتاری یا هیجانی فرد در مدرسه با هنجارهای تفاوت زیادی دارد به گونه ای که بر عمل کرد تحصیلی آن در زمینه های ،فرهنگ،قومیت یا ،پذیرفته شده و براساس سن رفتار کلاسی یا سازگاری شغلی اثر بگذارد ،شخصی پیشرفت تحصیلی،روابط اجتماعی سازگاریهای ،مراقبت از خود

اختلال های هیجانی یا رفتاری به شرایطی فراتر از پاسخهای موقتی به فشارزاهای (۱۳۹۶ ،هاردمن کلیفورد و اگن، ،تعریف دولت فدرال آمریکا از کودکانی که ناتوانیهای شدید هیجانی دارند .روانی موجود در محیط کودک یا نوجوان است چنین است عارضه ای که یک یا چند ویژگی زیر را به مدت طولانی و به مقدار زیاد دارد و موجب اختلال در تحصیل کودک میشود

-

-

یا جسمی ناتوانی در ایجاد یا حفظ رابطه رضایت بخش با همسالان و ،حسی ،ناتوانی در یادگیری بدون علتهای هوشی معلمان خود رفتارها یا احساسات غیر عدی تحت شرایط عادی

غم یا افسردگی فراگیر و دائم

(۱۳۹۶)ایجاد نشانههای فیزیکی با ترسهای مختلف مرتبط و مربوط به مشکلات شخصی و تحصیلی هاردمن و همکاران

این .تعریفی جدید را برای اختلالات رفتاری یا هیجانی ارائه داد (CCBD)البته شورای کودکان دارای اختلالات رفتاری بهداشت ،آموزشی،تعریف بعدها توسط جامعه بهداشت روانی ملی و آموزشهای خاص گروهی متشکل از ۳۰ سازمان از اختلالات رفتاری CCBDتعریف .(۲۰۱۷ ،مورگان و کنارد -آلبر ،روانی حمایت از کودکان به کار گرفته شد هووارد و هیجانی به صورت زیر است:

اصطلاح اختلال رفتاری با هیجانی به معنای یک نوع ناتوانی است که به وسیله واکنشهای رفتاری و هیجانی در برنامه این واکنشها .های مدرسه مشخص میشود

1. Council For Children With Behavioral Disorders

2. Heward

3. Alber-Morgan

4. Konrad

|||<>

%P. 4G Vos)

AT LTE1

:

Q

B

۱۵:۱۴

1_3784066676

>

اختلال های رفتاری و هیجانی

در همین موقعیتها است که کودکان با اختلالهای هیجانی یا رفتاری مشکل نشان ًمعمولا .رفتاری مناسب از خود نشان بدهند .میدهند و در برخی شرایط به نظر میرسد که آنها نسبت به محیطی که در آن قرار دارند بی توجه و بدون شناخت هستند

اکثر تعاریف .۱ تعریف اختلال رفتاری یا هیجانی تعریف کردن مشکلات رفتاری و هیجانی کودکان کار ساده ای نیست-۲ بر این فرض استوارند که کودکان مبتلا به اختلال رفتاری یا ناراحتیهای شدید هیجانی به طور دائم رفتار نامناسب سن را تعریفی روشن و .نشان میدهند و در نتیجه با کشمکشهای اجتماعی ناراحتیهای شخصی و شکستهای درسی روبه رو میشوند پذیرفته شده در مورد اختلالات رفتاری یا هیجانی به دلایل

.متعدد وجود ندارد

در مورد اینکه سلامت روانی خوب محصول چه عواملی است هنوز .اول اختلال رفتاری یک ساختار اجتماعی است اختلاف نظر وجود دارد همه کودکان گاه گاهی رفتارهای نامناسب از خود بروز میدهند یک دانش آموز چند وقت یکبار و با چه شدتی و به چه مدتی باید مشکل رفتاری از خود نشان دهد تا بتوان آن را اختلال رفتاری در نظر گرفت؟

دوم اینکه نظریه های مختلف اختلالات هیجانی از مفاهیم و اصطلاحاتی استفاده میکنند که معنی یک تعریف را از تعریف

هنجارها و انتظارات رفتاری در میان گروههای قومی و فرهنگی به میزان فراوانی ،سوم .دیگری چندان متمایز نمیکند متفاوت است.

در نهایت اختلالات رفتاری یا هیجانی گاهی همراه با دیگر ناتوانیها بروز پیدا میکن

کنند

به این معناست ً اختلال رفتاری معمولا .و در نتیجه مشکل میتوان دریافت که کدام شرایط علت یا معلول شرایط دیگر است نشانه غم و ناراحتی شخصی باشد؛ اما همه ً ناراحتی شدید هیجانی میتواند صرفا .که کودک برای دیگران مشکل می آفریند رفتار کودک تنها متغیری نیست که رده ،از طرفی .کودکان در برهه هایی از زمان رفتار نامناسب سن خود را نشان میدهند نقش کلیدی ،بلکه کسی که رفتار کودک را نامناسب تشخیص میدهد در این تصمیم گیری ،بندی در این طبقه را تعیین میکند مثل حمله نمیکی گریه دائم یا غم و بیش فعالی شدید ،بدیهی است که برخی رفتارها .دارد

د

۱۱۰ ۱۳۴

4G Vol)

:

شناخت اختلالهای هیجانی و رفتاری

1_3784066676

۱۵:۱۴

>

این آشفتگیها برخی دیگر از کودکان را چنان عقب میراند که گویی در دنیای خود زندگی میکنند در هر دو مورد .می گذرد بازی با دیگران پیدا کردن دوست و یادگیری تمام آنچه کودک باید یاد بگیرد برای این دسته از کودکان مشکل می شود.

اینها کودکان دارای اختلالات هیجانی یا رفتاری هستند.

از جانب هم کلاسیها و معلمانشان مورد بی محبتی قرار ،بسیاری از کودکانی که دارای اختلالات رفتاری یا هیجانی هستند میگیرند و حتی ممکن است از جانب والدینشان نیز طرد شوند کودک مبتلا به اختلالات رفتاری مشکل میتواند در میان جمع اگرچه .حاضر شود و تلاشهای دوست یابی وی اغلب به طرد شدن توهین های کلامی و حتی حملات فیزیکي منجر میشود

ذهن و بدن سالمی دارند لیکن اضطراب یا رفتارهای پسگرایانه آنها ،بیشتر کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری یا هیجانی همانند ناتوانی های هوشی حسی و فیزیکی در دیگر کودکان اغلب مانعی جدی بر سر راه یادگیری آنهاست.

همیشه از وجود کودکانی که دشواریهای رفتاری و هیجانی داشتند آگاه بوده ایم؛ اما به مرورزمان باورهای ما درباره علل دو قرن پیش این باور وجود .این رفتارها تغییرات جالبی به خود دیده و در نتیجه انواع مختلف درمانها مطرح شده است داشت که کودکان مبتلا به مشکلات رفتاری کسانی هستند که شیطان در وجودشان وارد شده است یا دیوانه و از نظر عقلی اگر هم این کودکان مورد توجه قرار می گرفتند به این صورت بود که آنها را در مکانهای بزرگ زندانی می .ناقص هستند متخصصانی که با این کودکان کار میکردند با کشیش ها .مکانهایی که در آنها کمتر به آموزش و پرورش بها میدادند .کردند (۱۳۹۵)بودند در صورتی که کودکان تحت استیلای شیطان بودند یا پزشکان کراتو چویل و موریس

نحوه ادراک ما از رفتار دیگران از عوامل کوناکونی تأثیر می پذیرد همچنین نحوه ادراک ما از رفتار دیگران تا حد زیادی باورها معیارها ارزشهای شخصی خود ما در مورد رفتار عادی است تحمل افراد با توجه به نوع رفتار و موقعیت ،از بسیار شخصی خود ما در مورد رفتارهای عادی است تحمل افراد با توجه به نوع رفتار و موقعیت بسیار متفاوت است (۱۳۹۶)افزون بر این آنچه از نظر عده ای عادی است از نظر عده ای دیگر غیر عادی به شمار میآید سلیگمن و روزنهان کودکان در موقعیتهای مورد علاقه خود باید کارهای جالب انجام دهند و

|||۵/۱۴

<>

%P. 40 Vo

4T LTE1

...

:

Q

B

1_3784066676

اختلال های رفتاری و هیجانی

اختلالهای عصبی رشدی ۱-۳-۱-۱ طبقه بندی اختلالهای هیجانی و رفتاری در کودکان ۱-۳

اختلالات عصبی رشدی اختلالاتی هستند که در آنها رشد و تحول مغز یا دستگاه عصبی مرکزی مختل شده و همزمان با فرد این اختلالات بر یادگیری رشد شناختی هیجانی و تعاملات اجتماعی و رفتاری فرد تأثیر میگذارند مطابق با ،رشد اختلالات طیف ،اختلالات ارتباطی ،این طبقه شامل شش دسته اختلالات یعنی اختلالات رشد عقلانی 5-DSMتغییرات در اینجا به دو مورد از آنها پرداخته .اختلال بیش فعالی نارسایی توجه اختلالات یادگیری و اختلالات حرکتی است ،اوتیسم ایگز ،ساکای)میشود

(۲۰۱۸ ،و هافمن

۱ اختلالات طیف اوتیسم-۳-۲

اوتیسم یا درخودماندگی یکی از اختلالات فراگیر رشدی با منشأ نورولوژیک و علائم روانشناختی است که سه حوزه مهم رفتاری را تحت تأثیر قرار میدهد:

-

تعامل اجتماعی

ارتباط کلامی و غیرکلامی الگوهای رفتاری کلیشه ای و تکراری

اختلالات مغزی توانایی فرد برای برقراری ارتباط و نحوه ارتباط وی با دیگران و ،با توجه به منشأ عصب شناختی اوتیسم پاسخهای فرد نسبت به محیط بیرون را تحت تأثیر قرار میدهد فرد درخودمانده به رفتارهای تکراری یا تکرار الگوهای دامنه و شدت اوتیسم بسیار وسیع است بعضی از این افراد می توانند در سطح بالایی با .ذهنی خود علاقه مند است اطرافیان خود ارتباط برقرار کنند و گفتاری خوب و هوش قابل قبولی دارند.

در حدود نیمی از .آسیب شناختی و زبانی بالایی دارند و حتی برخی هرگز قادر به صحبت کردن نیستند ،دسته ای دیگر ممکن است یک کودک درخودمانده از برقراری تماس چشمی خودداری کند .زبان باز نمی کنند ًکودکان درخودمانده اصلا است همچنین رشد زبان و مهارتهای اجتماعی وی متوقف.و یا به نظر برسد که ناشنوا

1. Sakai

2. ljaz

K

>%PY. LTE1

Q

۱۵:۱۴

1_3784066676 >

شناخت اختلالهای هیجانی و رفتاری

رفتارهای برونی سازی شده اغلب شامل موارد ،در کلاس درس .یا برونی سازی شده است ،رفتارهای ضداجتماعی

(۲۰۱۷)والکر ۱۹۹۷ به نقل از هو وارد و همکاران)پرتکرار زیر است

بیرون آمدن از صندلی

فریاد زدن بلند حرف زدن و فحش دادن

ایجاد مزاحمت برای همسالان

دعوا کردن و زدن

نادیده گرفتن معلم

اعتراض کردن

جرو بحث های زیاد

دردی

دروغ گفتن

تخریب وسایل دیگران

بدخلقی .

ناسازگاری

رفتارهای درونی سازی شده ـ۱ـ۲ـ۳

رفتاری همه نوع رفتاری از خود بروز میدهند الا پرخاشگری مشکل آنها ،برخی از کودکان دارای اختلالات هیجانی یا .در این حالت گفته میشود که این کودکان رفتارهای درونی سازی شده دارند .ارتباط اجتماعی بسیار پایین با دیگران است اگرچه کودکانی که به صورت مداوم رفتارهای نابالغ و گوشه گیرانه دارند تهدیدات کودکان ضداجتماعی را برای دیگران ایجاد نمیکنند اما رفتار آنها یک منع جدی در برابر رشدشان ایجاد میکند این کودکان به ندرت با همسالان خود بازی می به رویاپردازی و توهم اندیشی روی می ًآنها غالبا .کنند و فاقد مهارتهای اجتماعی لازم برای دوست یابی و تفریح هستند و همیشه از مریض بودن و آسیب دیدن گلایه دارند و در (فوبیا)برخی از آنها بدون دلیل از چیزهای خاص میترسند .آورند (۲۰۱۷)و همکاران (افسردگی های عمیق فرو میروند هووارد

|||۱۲

%P. 4G Vos)

4T LTE1

Q :

B

۱۵:۱۴

1_3784066676 >

اختلال های رفتاری و هیجانی

فنی ،آنچنان از اقتضائات سنی و هنجارهای قومی و فرهنگی فاصله دارند که عملکرد تحصیلی از جمله مهارتهای اجتماعی و حرفهای تحصیلی و یا شخصی را تحت تأثیرات منفی خود قرار میدهند؛ و بیش از یک واکنش مورد انتظار و موقتی به رویدادهای پراسترس در محیط تلقی میشوند این واکنشها به صورت مداوم در دو محیط مشهود هستند و حداقل یکی از این تحصیل یا شرایط کودک به گونه ایست .محیطها مرتبط با مدرسه است و به طور کلی مداخله مستقیم در آنها بی تأثیر است که مداخلات تحصیلی عمومی برای وی

ناکافی است.

این اصطلاح شامل اختلال اسکیزوفرنی اختلال .این اصطلاح شامل یک نوع ناتوانی است که با دیگر ناتوانیها همراه است یا دیگر اختلالات پایدار رفتاری و سازگاری است و در صورتی که عملکرد تحصیلی ،اختلال اضطراب (عاطفی)محبت

آن است CCBDمزایای این تعریف براساس .را آن گونه که تحت تأثیر قرار دهد میتواند کودک را به این اختلال دچار کند که ابعاد تحصیلی این ناتوانی را روشن میسازد؛ بر رفتار کودک در محیط مدرسه تمرکز دارد؛ رفتار را در بافت مناسب هنجارهای سنی قومی و فرهنگی بررسی میکند و احتمال شناسایی سریع و مداخله را افزایش میدهد مهمتر از همه واژه این تفاوت ها .شناسیهای اصلاح شده در تعریف در برگیرنده تفاوت های جزئی بین ناسازگاری اجتماعی و عاطفی نیستند جدی و آشکار ًاغلب منابع تشخیصی را زمانی که مشکل به صورت کاملا

(۲۰۱۷)و همکاران (وجود دارد هدر میدهند هو وارد

از ً۱ ویژگیهای کودکان با اختلالهای رفتاری و هیجانی کودکانی که دارای اختلالات رفتاری و هیجانی هستند اساسا-۲-۱ برونی سازی شده یا درونی سازی شده شناسایی میشوند که بسیار فراتر از هنجارهای سنی و فرهنگی)طریق رفتارهایی هر یک از الگوهای رفتار نابهنجار دارای اثرات منفی بر پیشرفت تحصیلی و روابط اجتماعی است .قرار میگیرند (ساراسون و ساراسون، ۱۳۹۲).

رفتارهای برونی سازی شده -۱-۲-۲

شامل ،رایج ترین الگوی رفتاری کودکان دارای اختلالات هیجانی یا رفتاری

4G Vos)

%PY. LTE1

VO/13: Adelman

۱۷۵/۱۸

۱۳

شناخت اختلالهای هیجانی و رفتاری

1_3784066676

۱۵:۱۵

>

.سکوت انتخابی گاه در افراد اوتیستی و یا دارای آسپرگر نیز دیده میشود .باشد.ساکت باشد ولی در خانه برعکس پرحرف انتخابی کاه شخص به اشتباه دارای اختلالات طیف اوتیسم دانسته می ،به طور خاص در کودکان مبتلا به سکوت و کنکی

.شود

قبل از پنج سالکی شروع میشود ولی احتمال دارد تا زمان ورود کودک به دبستان مورد توجه بالینی ًلالی انتخابی معمولا قرار نگیرد و والدین تصور میکنند شاید کودک آنها از صحبت در برخی جمعها خودداری میکند این اختلال باعث می شود کودک در پیشرفت اجتماعی شغلی یا ارتباطات اجتماعی با مشکل روبه رو شود و این اختلال برای اینکه تشخیص داده شود ،لازم است حداقل یک ماه دوام داشته باشد و به اولین ماه ورود به مدرسه نیز مربوط نباشد انجمن روان پزشکی آمریکا (۲۰۱۳).

هر اسهای ویژه یا فوبیاهای خاص هر اسهای ویژه یا فوبیاهای خاص شامل ترس غیر منطقی و نامعقول از یک موضوع یا مشتق شده ،فوبیا ریشه یونانی دارد و از فوبوس یکی از خدایان یونانی که دشمن خود را می ترساند .موقعیت خاص است ترس بسیار شدیدی ایجاد می کنند و همین دلیل افراد فوبیک برای اجتناب از آنها ًمحرک های خوبی را معمولا .است برخی از هراس (استراتژیهایی به کار میبرند تا احتمال مواجه شدن با محرکهای فوبی را به حداقل برسد رفتارهای ایمنی فوبیای حیوانات ترس شدیدی که دلیلش یک حیوان یا حشره باشد مانند ترس از مار عنکبوت جوندگان سگ (های ویژه الف و نظایر آن

فوبیای اجتماعی (ب

فوبیای (آب تاریکی و بلندی د،ج فوبیای عوامل طبیعی ترسی که دلیلش عاملی در طبیعت باشد همچون ترس از توفان خون زخم و و آمپول

پرواز ،فوبیای موقعیتی ترس شدیدی که با قرار گرفتن در یک موقعیت خاص ایجاد می شود مانند هراس از آسانسور (ه .....تونل پلها ،دندان پزشکی

1. Specific Phobia

|||۷۵/۱۶

:

%PP. 4G Vos)

Q

AT LTE1

1_3784066676

۱۵:۱۴

>

اختلال های رفتاری و هیجانی

سامانه طبقه بندی آماری است کودکان با اختلالهای اضطرابی در موقعیت های اضطراب برانگیز و جدایی از والدین و مربیان این افراد در مورد اتفاقهای).افرادی که به آنها دل بستگی دارند مشکل دارند برای مثال دوستان صمیمی معلمان و آینده و پیشرفت خود نگران هستند مرتب در پی کسب تأیید هستند و شکایتهای جسمانی از ویژگیهای مشخص آنها در دوره هاردمن و)اوایل جوانی است

همکاران ۱۳۹۶

اختلال اضطراب جدایی نوعی اختلال روانی است که در آن فرد به علت جدا شدن از خانه یا از افرادی که به آنها وابستگی .مادر پدربزرگ مادر بزرگ فرزندان و یا خواهران و برادران به شدت مضطرب میشود ،عاطفی زیادی دارد پدر در عملکرد تحصیلی یا اجتماعی نابسامانی شدید به وجود ((مثلا)اضطراب جدایی میتواند در جنبه های مختلف زندگی :آورد از نشانه های این اختلال عبارت است از

ه خودداری از رفتن به مدرسه

ه نگرانی بیش از حد در مورد صدمه یا آسیب زدن به خود یا دیگر اعضای خانواده ه بی میلی در خوابیدن و شکایتهای در ۱۲ تا ۱ اضطراب جدایی معمولا (۲۰۱۳)انجمن روان پزشکی آمریکا)دل درد حالت تهوع -مکرر در مورد سردرد این .در سالهای پیش دبستانی مشاهده میشود ۱۸ ماهگی روی میدهد اما اختلال اضطراب جدایی برای اولین بار معمولا اضطراب جدایی بخشی .اختلال ممکن است در هر سنی آغاز شود اما شروع آن در نوجوانی و بزرگسالی نادر است .(این اختلال به طور مفصل تر در فصل چهارم بحث میشود .است.طبیعی از فرایند رشد و نمو

در

لالی انتخابی یا گنگی انتخابی نوعی اختلال است که در آن شخص باوجوداینکه حالت عادی قادر به تکلم است در موقعیتهایی خاص یا در برابر افرادی خاص قادر به حرف زدن نیست این اختلال ممکن است به همراه خجالت و اضطراب رفتار شخص از نگاه دیگران می تواند به اشتباه بی احترامی برداشت شود کودک مبتلا (۲۰۰۷)اجتماعی باشد ادلمن

ممکن است در مدرسه همیشه

1. Separation Anxiety Disorder

2. Selective Mutism

VO/13. Adelman

|||

>1. Sakai

2. ljaz

%P. 4G Vos)

AT LTE1

Q :.

B

1_3784066676

۱۵:۱۴

>

شناخت اختلالهای هیجانی و رفتاری

درواقع اوتیسم اختلالی است که به طور عمده ارتباطی ،هسته مرکزی مشکل در اوتیسم اختلال در ایجاد ارتباط است .شود است تا زبانی و این جزء معیارهای اصلی اختلال است که به آسیب دیدگی عملکرد اجتماعی و برقراری ارتباط و تأخیر یا افراد در خود مانده زمان زیادی را صرف .انحراف در مراحل اولیه دوران رشد کودک در ارتباط اجتماعی و بازی میشود ،به نقل از ساراسون و ساراسون ،فریت ۲۰۰۴،تماشای اشیای چرخان ریتم گرفتن با انگشتان یا تکان دادن بدنشان میکنند ۱۳۹۲).

در دسته اختلالات رشدی عصبی و به DSM-5این اختلال در (ADHD)بیش فعالی -۱ اختلال نارسایی توجه -۳-۳ نوجوانان و ،کودکان ،یک اختلال روان پزشکی است که کودکان پیش دبستانی .عنوان یک اختلال مستقل آورده شده است بزرگ سالان سراسر جهان را مبتلا کرده و مشخصه آن الگوی کاهش پایدار توجه و افزایش تکانشگری و بیش فعالی است

کودک توانایی دقت و تمرکز بر روی یک موضوع را نداشته یادگیری در او ً معمولا (۲۰۱۳) ،انجمن روان پزشکی آمریکا توجه فعالیت بیش از حد ،این اختلال با فقدان .کند است و کودک از فعالیت بدنی غیر معمول و بسیار بالا برخوردار است بسیاری از این کودکان یک یا چند اختلال رفتاری دیگر نیز دارند .رفتارهای تکانشی یا ترکیبی از این موارد همراه است (میلیشاپ، ۲۰۱۰).

ADHD شایع ترین اختلال رفتاری در سنین کودکی و بلوغ است و حدود ۵ تا کودکان سنین مدرسه به آن مبتلا میشوند این عارضه بیشتر در دوران ابتدایی مدرسه برای کودکان و در هنگام بلوغ رخ (۲۰۱۳)انجمن روان پزشکی آمریکا (اختلال به طور مفصل تر در فصل سوم بحث میشود (میدهد و با افزایش سن ۴۰ درصد از بیماران بهتر میشوند این اختلالهای اضطرابی و هراسهای ویژه فوبیاهای خاص طبقه اختلال های اضطرابی دوران کودکی و نوجوانی بسیار شبیه .

گوشه گیری در -طبقه اضطراب

1. Attention-Deficit Hyperactivity Disorder

2. Neurodevelopmental Disorders

3. American Psychiatric Association

>%P. 4G Vos)

AT LTE1

:.

Q

B

۱۵:۱۵

1_3784066676 >

اختلال های رفتاری و هیجانی

احضار آتش نشانی علاقه نشان میدهند کنجکاوی آنها بسیار مشهود است ولی نسبت به اعمال خود هیچ گونه احساس پشیمانی ندارند و نسبت به پیامدهای آتش برای زندگی انسانها و اموال آنها بی تفاوت هستند آتش افروزها ممکن است از تخریب ناشی از آتش احساس رضایت کنند و اغلب سرنخ های آشکاری برجا

می گذارند.

اختلال دزدی بیمارگون خصوصیت اصلی اختلال دزدی بیمارگون ناتوانی مکرر برای مقاومت در مقابل تکانه های دزدی اشیائی است که برای مصرف شخصی ضرورتی ندارند یا ارزش مادی خاصی ندارند اشیای دزدیده شده اغلب دور انداخته توانایی ً بیماران مبتلا به جنون دزدی معمولا .میشوند و یا به طور پنهانی بازگردانده میشوند و یا در خفا نگهداری می شوند در اختلال جنون دزدی مثل سایر (۲۰۱۳)خرید اشیائی که به طور تکانشی میدزدند را دارند انجمن روان پزشکی آمریکا تکانه شخص قبل از ارتکاب عمل تنش قابل ملاحظه ای دارد و پس از انجام آن احساس رضایت و کاهش تنش ،اختلالات دزدی برنامه ریزی شده نبوده و شخص .میکند و ممکن است با احساس گناه پشیمانی و یا افسردگی همراه باشد یا نباشد کسی را در آن درگیر نمیکند هرچند سرقت ها در مواردی که احتمال دستگیری فوری وجود دارد روی نمیدهند ولی مبتلایان به جنون دزدی همیشه به احتمال گرفتار شدن خود نمی اندیشند حتی اگر دستگیری های مکرر منجر به رنج و در جنون دزدی نفس دزدی هدف .تحقیر شود

است.

مشخصه ً اختلال سلوک اختلال سلوک شامل رفتارهایی پایداری است که با گذشت زمان شکل میگیرد و غالبا ویرانی و تخریب ،پرخاشگری (آمریکا ۲۰۱۳،آن پرخاشگری و تجاوز به حقوق دیگران است انجمن روان پزشکی این اختلال در .اموال سرقت و تقلب دروغ گویی و مواردی نظیر آن در میان کودکان مبتلا به اختلال سلوک مشاهده میشود ندارد بلکه مشکلات سلوک.پسران رایج تر است و در سطح جهانی دیده میشود این مشکل اختصاص به موقعیت ،میان مدرسه خانه جامعه و با همسالان مشاهده میشود،در.

1. Kleptomania

۱۷۵2 Conduct Disorder (CD)

|||

۱۶...

%P. 4G Vos)

++ LTE1

<>

Q

B

Disorder

۱۵:۱۵

1_3784066676 >

شناخت اختلالهای هیجانی و رفتاری

۱۵

شد با نافرمانی پاسخ داده و ایجاد فرایند ارتباطی را با مشکل مواجه میسازند به صورتی که اغلب والدین این کودکان روابط مثبت خود را با این کودکان از دست داده و به جای این روابط مثبت تعاملات منفی جایگزین خواهد شد و این کودکان را هر چه بیشتر به سوی علائم وخیم تر همچون علائم اختلال سلوک

اختلال انفجاری .اختلال انفجاری متناوب .(هدایت خواهد کرد این اختلال به طور مفصل تر در فصل پنجم بحث میشود پرخاشگری رفتارهای خشونت آمیز و طغیان کلامی است که به طور متناوب و ،شامل ضربه های ناگهانی 'متناوب کند عصبانیتهای بروز کرده در جاده خشونت خانگی پرتاب اشیا یا دیگر بداخلاقیها علائم اختلال .تکراری بروز می (۲۰۱۳)انفجاری متناوب میباشند انجمن روان پزشکی آمریکا

این طغیان های متناوب باعث پریشانی قابل توجهی میشوند و بر روی روابط فرد در محل کار و مدرسه تأثیر منفی اختلال انفجاری متناوب نوعی اختلال مزمن است که سالها ادامه .میگذارند و پیامدهای مالی و حقوقی در پی خواهند داشت خواهد داشت اما شدت آن با افزایش سن کاهش مییابد.

اختلال آتش افروزی اختلال آتش افروزی عبارت است از برپا کردن آتش به صورت مکرر و هدفمند خصوصیات مرتبط با آن عبارت اند از؛ احساس تنش یا انگیختگی عاطفی پیش از آتش افروزی شیفتگی علاقه یا کنجکاوی و مجذوبیت نسبت به رضایت یا تسکین هنگام آتش افروزی یا هنگام مشاهده آتش یا ،احساس لذت ،فعالیتها و تجهیزات مرتبط با آتش نشانی ،آتش بیماران ممکن است پیش از شروع آتش افروزی تدارکات (۲۰۱۳)انجمن روان پزشکی آمریکا)شرکت در پیامدهای آن اختلال آتش افروزی با ایجاد آتش از این نظر متفاوت است که حالت دوم به .پیشرفته قابل ملاحظه ای در نظر بگیرند منظور نفع مالی انتقام گیری یا سایر دلایل انجام میشود و از قبل برنامه ریزی شده است انجمن روان پزشکی آمریکا

مبتلایان به اختلال آتش افروزی از تماشاگران همیشه حاضر آتش در حوالی منزل خود هستند به کرات زنگهای (۲۰۱۳)
خطر را به دروغ به صدا در می آورند و نسبت به
۱۷۵/۲۰
1. Intermittent Explosive Disorder
2. Pyromania<>
%P. 4G Vos)
AT LTE1
:
Q
B
۱۷۵/۱۸
۱۵:۱۵
1_3784066676 >
اختلال های رفتاری و هیجانی
فوبیای ارتفاع (فوبیای دندان پزشکی ز (و
نرخ شیوع در کودکان حدود ۵٪ و در ۱۳ تا ۱۷ ساله ها حدود ۱۶ است انجمن روان .هراس های ویژه شایع هستند
از دوران کودکی یا نوجوانی آغاز میشوند و حدود ۵۰٪ آنها هم ظرف مدت پنج سال خود ״۲۰۱۳ معمولا)آمریکا ،پزشکی
هواپیما مکانهای بسته یا ارتفاع ممکن است در اوایل بزرگ سالی نیز ،به خود برطرف میشوند مواردی نظیر ترس از
ایجاد شوند این اختلال به طور
مفصل تر در فصل چهارم بحث میشود
براساس کتاب راهنمای تشخیصی و آماری (ODD)مخرب کنترل تکانه و سلوک اختلال نافرمانی مقابله ای ،اختلالات
یکی از اختلالهای طبقه بندی شده در طبقه اختلالهای برونی سازی شده است که مهمترین (5-DSM)اختلالات روانی
لجبازی نافرمانی و خصومت در برابر مظاهر قدرت است که ،گرایی ،مشخصه آن الگوی پایدار رفتار تکراری منفی

حداقل ۶ ماه دوام داشته است متناسب با سن تحولی کودک نیست و باعث اختلال قابل ملاحظه بالینی در فعالیتهای تحصیلی کودک مبتلا به این اختلال برای هر چیزی جر و بحث راه میاندازد رفتار کینه توزانه و انتقام .اجتماعی و شغلی فرد میشود

از انجام ًدارد بیش از حد زودرنج و حساس است فعالانه و عمدا،جویانه

در اشتباه ها و مشکلات خود دیگران را مقصر میداند و ،درخواست های والدین سر باز میزند باعث ناراحتی آنها میشود در برابر افراد بزرگسالی رخ ً باید به این اختلال شک کنند زیرا این رفتارهای مقابله جویانه معمولا ،آنها را سرزنش میکند میدهد که کودک یا نوجوان با آنها آشناست؛ مانند والدین و در مواردی نیز معلمان و اولیای مدرسه انجمن روان پزشکی

کودکان مبتلا به این اختلال اغلب با همسالان والدین معلمان و سایر موقعیت هایی که ارتباط مناسب (۲۰۱۳)آمریکا

اغلب این کودکان در برابر تمامی درخواستهایی که از جانب والدین و دیگر .اجتماعی را طلب میکند دارای مشکل هستند

همسالان مطرح خواهد

۱۳:

%PY. LTE1

<>

۱۹

1_3784066676

۱۵:۱۵

>

شناخت اختلالهای هیجانی و رفتاری

-

این کودکان از ۲ یا ۵ سالگی هنوز در .اختلال دفع به ادرار کردن و مدفوع کردن در کودکان بزرگ سال تر مربوط میشود

.کنترل مدفوع و ادرار مشکل دارند و این وضعیت به این وضعیت به اختلال جسمانی مربوط نمی شود

شایان ذکر است که .حدود یک درصد کودکان ۵ ساله اختلال مدفوع دارند و این اختلال در پسران شایع تر از دختران است

تا قبل از ۲ سالگی نمیتوان تشخیص اختلال مدفوع را مطرح کرد زیرا ممکن است بی اختیاری در دفع از عوامل زمینه

.اجتماعی ناشی شود -سازی مانند آموزش ناکافی و ناهماهنگی آداب توالت رفتن و استرسهای روانی

رختخواب بدون اینکه ،بی اختیاری ادرار بی اختیاری ادرار عبارت است از دفع مکرر ادرار طی روز یا شب در لباسها یا آسیبی در مجاری ادرار وجود داشته یا

دفع ادرار در اغلب موارد غیرارادی است (۲۰۱۳)علت عصب شناختی دیگری مطرح باشد انجمن روان پزشکی آمریکا

این تشخیص مستلزم آن است که دفع ادرار حداقل دو بار در هفته و به مدت سه ماه .گاه ممکن است ارادی هم باشد باشد ..حداقل سن تقویمی کودک بهنجار باید ۵ سال .رخ دهد و موجب اختلال در کارکردهای اجتماعی یا تحصیلی فرد شود

انواع فرعی بی اختیاری ادرار شامل نوع فقط شبانه .بی اختیاری ادرار نباید از عوارض مستقیم مصرف دارو ناشی شود نوع فقط روزانه و نوع شبانه و روزانه به صورت توام است.

است .زمان وقوع این روادید اغلب در طی یک سوم نخست شب .شایع ترین نوع بی اختیاری ادرار است ،نوع فقط شبانه گاهی هم طی مرحله ای که خواب با حرکت سریع چشم رخ میدهد و کودک ممکن است رؤیایی در زمینه عمل ادرار کردن تعریف کند اتفاق می افتد.

بی اختیاری ادرار روزانه در دختران شایعتر .روزانه بی اختیاری ادرار در طی ساعات روز مشاهده میشود،در نوع فقط از پسران است و پس از ۹ سالگی نیز بسیار نادر است این روادید اغلب در اوایل بعد از ظهر به ویژه در مدرسه رخ میدهد.

گاهی بی اختیاری ادرار روزانه بر اثر امتناع از رفتن به دستشویی به دلیل اضطراب اجتماعی یا اشتغال به بازی و فعالیتهای مدرسه ای است.

۵/۲۴

1. Enuresis

|||%, 4G Vos)

AT LTE1

D

Q

B

1_3784066676

۱۵:۱۵

>

اختلالهای رفتاری و هیجانی

هزره خواری در کودکان به همراه ًکچ یا حتی رنگ باشد معمولا،مو ،این مواد ممکن است پارچه نخ .مدت یک ماه است

اختلالهای رشدی فراگیر دیده می شود پراشتهایی عصبی یا جوع اختلالی است که در آن فرد از افزایش وزن می ترسد و

کلمه ای یونانی و به معنای گرسنگی گاو نر است گرسنه به ،درباره اندام خود تصورات غیر واقعی دارد بولیمیا یا جوع

تخمینهای شیوع این اختلال بین ۲ تا ۴ درصد در .اندازه گاو نر پراشتهایی عصبی شایع تر از بی اشتهایی عصبی است

همچون بی اشتهایی عصبی پراشتهایی عصبی نیز در زنان بسیار شایع تر از مردان است ولی سن .زنهای جوان است

عصبی (۲۰۱۳)شروع آن در دوره نوجوانی دیرتر از سن شروع بی اشتهایی است انجمن روان پزشکی آمریکا

اختلالات دفع

بی اختیاری دفع مهمترین ویژگی بی اختیاری مدفوع دفع مکرر مدفوع در محلهای نامناسب مانند درون لباس اتاق و غیره

این عمل حداقل باید به مدت سه ماه و .این کار اغلب به صورت غیرارادی رخ میدهد ولی گاه چه بسا عمدی باشد .است

سن تقویمی کودکان بهنجار باید حداقل چهار ،حداقل ماهی یک بار مشاهده شود برای تشخیص این مسئله در مورد کودکان

انجمن)ناتوانی در کنترل دفع نباید از عوارض فیزیولوژیکی داروها یا مواد و یا بیماری جسمانی ناشی شود .سال باشد

(۲۰۱۳)روان پزشکی آمریکا

یبوست ممکن است ناشی از مسائل روان شناختی مانند .در مواردی که عمل دفع غیرارادی است اغلب یبوست وجود دارد

کودکان با بی .بی اختیاری مدفوع چه بسا با یبوست یا بدون آن همراه است .اضطراب از دفع در مکانی خاص باشد

اختیاری مدفوع اغلب گوشه گیر و خجالتی اند و تمایل چندانی به شرکت در موقعیتهای اجتماعی ندارند این کودکان به دلیل

،در مواردی که دفع به صورت عمدی رخ میدهد .عدم پذیرش از سوی مربیان و همسالان از عزت نفس پایینی برخوردارند

بسیاری .ویژگیهای اختلال سلوک نیز در آنان مشاهده میشود

.از این کودکان بی اختیاری ادرار نیز دارند

1. Bulimia Nervosa VO 2. Focopresis

۱۸%, 4G Vos)

AT LTE1

:.

Q

B

. Kleptomania

. Conduct Disorder (CD)

۲۲

1_37840666765/۲۶

۵/۲۷

%P. 4G Vos)

IT LTE1

:

Q

B

۱۵:۱۵

1_3784066676 >

۲۲

اختلال های رفتاری و هیجانی

خودآزمایی چهارگزینه ای فصل اول

۱. نخستین تلاشهای مستند در زمینه کودکان با نیازهای خاص توسط کدام دانشمند انجام شده است؟

الف) فروید

ب) اسکینر (ایتارد د

ج) بینه

۲. نخستین طبقه بندی از رفتار بهنجار و نابهنجار توسط کدام دانشمند ارائه شده است؟

الف) ایتارد

ج) پیاژه

ب) پنیل

د) آخنباخ

. در دوران شیرخوارگی چیزهای مختلف را به دهان میبرند لیکن بعد از یک سن خاص این عمل غیر ًکودکان معمولا

در چه سنی اتفاق میافتد؟ ًنامیده میشود این رفتار معمولا (هرزه خواری)طبیعی بوده و اصطلاح آن پیکا

الف) ۶ ماهگی

ج) ۵ سالگی/۱

ب) ۱ سالگی

د) ۲ سالگی

حداقل سن برای تشخیص بی اختیاری ادرار باید چند سال باشد؟

الف) ۶ سال

ج) ۴ سال

ب) ۵ سال

د) ۳ سال

الگوی رفتاری که شامل نقض حقوق دیگران است و همراه با پرخاشگری فیزیکی ،خسارت به اموال و ،دیگران دزدی

دروغ گویی است جزء کدام اختلال محسوب

می شود؟

الف) سلوک فراگیر رشد ج)

ب نافرمانی مقابله ای

د) بیش فعالی/نقص توجه

شیوع کدام نوع از فوبیا در دو جنس مساوی و یکسان DSM-5و مطابق با معیارهای

است؟

فوبی حیوان (الف

فوبی پرواز (ج

آمپول و زخم ،فوبی خون (ب

فوبی دندان پزشکی (د

کدام یک از اختلالات زیر میتواند جنبه تکلمی داشته باشد؟

بیش فعالی (ب

آتش افروزی

فوبی (الف

اوتیسم (ج

۱۵:۱۵

>

شناخت اختلالهای هیجانی و رفتاری

۱۷

خانوادگی فقدان نظارت ،روش تربیتی خشن و تهیه اختلافات ،علل این اختلال ممکن است سطح پایین اقتصادی و اجتماعی

اختلال به طور مفصل تر در فصل ششم بحث میشود؟ (مناسب والدین و فقدان کفایت اجتماعی ارتباط داشته باشد این اختلال شخصیت ضد اجتماعی اختلال شخصیت ضداجتماعی عبارت است از ناتوانی از تن دادن به هنجارهای اجتماعی به انجمن روان)طوری که جنبه های متعددی از رفتار فرد در نوجوانی و بزرگسالی تحت تأثیر این ناتوانی قرار گرفته باشد

مشخصه این اختلال اعمال مداوم ضداجتماعی یا .(۲۰۱۳)آمریکا ،پزشکی

میزان شیوع اختلال شخصیت ضداجتماعی در مردان سه .خلاف قانون است اما این اختلال مترادف با بزهکاری نیست

این اختلال از همه بیشتر در نواحی فقیر نشین شهری و در جمعیت غیر ثابت این .درصد و در زنان یک درصد است

خانواده هایی بزرگتر از دختر بچه های مبتلا به این اختلال ،نواحی شیوع دارد پسربچه هایی که مبتلا به این اختلال اند

پیش از رسیدن به سن بلوغ و پسربچه ها ً دختر بچه ها معمولا .داشته اند این اختلال پیش از پانزده سالگی شروع میشود

(۲۰۱۳)حتی از این هم زودتر علائمی دارند انجمن روان پزشکی آمریکا

اختلال

(پیکا)موارد زیر در دسته اختلالات خورد و خوراک جای گرفتهاند هرزه خواری DSM-5اختلالهای خورد و خوراک در غذا بی اشتهایی عصبی پراشتهایی عصبی و پرخوری از ،نشخوار اختلال مصرف غذای دوری جو محدود کننده ،اختلال بین موارد یاد شده هرزه خواری و پراشتهایی عصبی مورد بحث قرار می گیرد.

بیشتر مواقع از روی .داخل دهانشان می گذارند ،هرزه خواری بسیاری از کودکان هر چیزی را که دم دستشان باشد کنجکاوی و با هدف کشف محیط اطراف این کار را انجام میدهند؛ اما کودکانی که مبتلا به پیکا یا اختلال هرزه خواری باشند از این سطح اکتشاف طبیعی فراتر میروند و به صورت سیری ناپذیری شروع به خوردن مواد غیر غذایی میکنند.

ملاک تشخیص خوردن مواد غیر خوردنی دست کم برای

1. Antisocial

2. Criminality 3. Pica

|||

>۵/۲۶

<>

۱۱۰ ۱۳۴

۲۱

4G Vo)

Q

B

شناخت اختلالهای هیجانی و رفتاری

1_3784066676

۱۵:۱۵

>

.فعالیت های درسی تماس کمتر با دوستان و کیفیت پایین تر ارتباط در مقایسه با همسالان بدون معلولیت خود هستند

خلاصه فصل اول

معدل حد وسط معتدل و معمولی اطلاق میشود و نابهنجار آنچه را که از حد وسط ،کلمه بهنجار از نظر لغوی به مفهوم اعتدال و معمولی منحرف باشد را در ذهن تداعی می کند اختلالهای هیجانی یا رفتاری به شرایطی گفته میشود که در آن تفاوت زیادی ،فرهنگ،قومیت یا ،پاسخ های رفتاری یا هیجانی فرد در مدرسه با هنجارهای پذیرفته شده و براساس سن دارد.

کودکان با اختلالهای رشدی فراگیر نارساییهای شدید و فراگیری در حوزه های متفاوت رشد نشان میدهند این نارساییها دیگران مهارتهای ارتباط بسیار ،همشیران و ،والدین ،ممکن است شامل مشکلات قابل توجهی در مورد ایجاد ارتباط با اوتیسم یکی از اختلالات فراگیر رشدی با منشأ .ضعیف رفتارهای غیر عادی مشهود در وضعیت بدنی حالت و چهره بشود سندرم آسپرگر شکل ملایمی از طیف اوتیسم شمرده میشود و وجه تمایز آن حفظ .نورولوژیک و علائم روان شناختی است .مهارت های گفتاری کافی در زمینه های لغت و گرامر و هوش معمولی و حافظه بلند مدت قوی است

کودکان با اختلالهای اضطرابی در موقعیتهای اضطراب برانگیز و جدایی از

اختلال نافرمانی مقابلهای یکی از اختلالهای طبقه بندی شده در .والدین و افرادی که به آنها دل بستگی دارند مشکل دارند طبقه اختلالهای برونی سازی شده است که مهمترین مشخصه آن الگوی پایدار رفتار تکراری منفی گرایی لجبازی نافرمانی و خصومت در برابر مظاهر قدرت است که حداقل ۶ ماه دوام

.داشته است

بسیاری از دانش آموزان دارای اختلالات رفتاری و هیجانی در مقایسه با کودکان بدون معلولیت در آزمونهای هوش بهر دانش آموزان مبتلا به اختلالات رفتاری دارای سطح پایین تری از احساس همدلی .نمره پایین تر از میانگین کسب میکنند دیگران شرکت در فعالیتهای درسی تماس کمتر با دوستان و کیفیت پایین تر ارتباط در مقایسه با همسالان بدون ،نسبت به .معلولیت خود هستند

|||

>%PP. 4G Vos)

AT LTE1

Q

B

1_3784066676

۱۵:۱۵

>

۲۰

اختلال های رفتاری و هیجانی

هیجانی در مقایسه ،هوش کودکان دارای اختلالات رفتاری یا هیجانی بسیاری از دانش آموزان دارای اختلالات رفتاری و .
کنند گفتن اینکه آیا کودکان مبت .با کودکان بدون معلولیت در آزمونهای هوش بهر نمره پایین تر از میانگین کسب می
اختلالات رفتاری و هیجانی در مقایسه با کودکان سالم هوش پایین تری دارند یا خیر کاری مشکل است تست هوش بهر
روشن است که رفتار تخریبی که یک ً انجام مطلوب یک فعالیت مشخص را در زمان و مکان اجرای تست میسنجد تقریبا
کودک مبتلا به اختلالات رفتاری یا هیجانی از خود بروز میدهد با فرصتهای گذشته وی برای یادگیری فعالیتهای تست
۲۰۱۷ تخمین زده اند)به نقل از هووارد و همکاران (۲۰۱۰)رود و همکاران .(۱۳۹۶ ،و همکاران (تداخل دارد هاردمن
۸۵ درصد به تکالیف معلم پاسخ داده و در کلاس شرکت میکنند؛ لیکن دانش آموزان دارای ً که دانش آموزان متوسط تقریبا
اختلالات رفتاری و هیجانی تنها ۶۰ درصد و کمتر به فعالیتهای درسی و کلاسی مبادرت می ورزند کارهای متفرقه و
توجه معلم را جلب کرده و رفتارهای ناخواسته ای را در وی بر می انگیزند یکی ً رفتارهای تخریبی این دانش آموزان مرتبا
این است که به آنها یاد بدهیم توجه دیگران را با رفتارهای خوب و ،از استراتژیهای تحقیقی برای شکستن این الگو
مناسب جلب کنند.

مهارت های اجتماعی و روابط بین فردی توانایی توسعه و حفظ روابط بین فردی در کودکی و نوجوانی یکی از عاملهای
همان گونه که انتظار میرود دانش آموزان دارای اختلالات رفتاری و هیجانی اغلب توسط دوستان .سازگاری در آینده است
از میان مطالعات بسیاری که در .خود طرد میشوند و در دوست یابی و حفظ دوستانشان مشکلات جدی را تجربه می کنند
شونرت)رابطه با مهارتهای اجتماعی دانش آموزان دارای اختلالات رفتاری و هیجانی انجام شده نتایج یکی از مطالعات
۱۹۹۳ به نقل از هووارد و همکاران ۲۰۱۷ که روابط اجتماعی دانش آموزان متوسطه دارای اختلالات رفتاری و ،راشل

هیجانی را با دانش آموزان هم سن آنها و بدون معلولیت را بررسی کرده است نشان میدهد که دانش آموزان مبتلا به اختلالات رفتاری دارای سطح پایین تری از احساس همدلی نسبت به دیگران شرکت در

فتاء .شناخت اختلالهای هیجان

7%PP. 4G Vos)

AT LTE1

:

Q

B

۱۷۵/۲۹

1_3784066676

۱۵:۱۵

اختلال های رفتاری و هیجانی

>

۲۶

.کودکی پیش بینی کننده افزایش احتمال ابتلای به اختلالات روان پزشکی در دوران نوجوانی و بزرگسالی است

اختلال های رفتاری به شرایطی گفته میشود که پاسخهای هیجانی و رفتاری فرد در مدرسه با هنجارهای سنی فرهنگی و این .مراقبت از خود روابط اجتماعی و سازگاری فردی تأثیر منفی بگذارد ،قومی در تناقض باشد و بر عملکرد تحصیلی .(۲۰۱۳ ،سالیک)اختلالها باید دست کم در دو موقعیت متفاوت بروز کنند

در سال های اخیر توجه به مسائل و مشکلات رفتاری کودکان به عنوان یکی از موضوعات عمده بهداشت روان افزایش کودکان قسمت عمده ای از جمعیت هر جامعه را تشکیل میدهند و از سوی دیگر بسیاری از ،یافته است؛ زیرا از یک سو کودکان در سالهای نخستین کودکی دارای مشکلات عاطفی و رفتاری هستند که نه تنها به سادگی از آن عبور نمی کنند بلکه .(۲۰۱۷ ،پولمان شولت و سونگ ،"لی ،ممکن است این امر تا دوران بلوغ و حتی بزرگ سالی نیز تداوم یابد کایسر

براساس مطالعات انجام شده حداقل ۲۲ درصد کودکان و نوجوانان در سنین مدرسه مشکلات جدی و مستمر هیجانی یا

،مونیکا و کارگ ،گوپتا)رفتاری دارند که درصد قابل توجهی از این مشکلات ممکن است تا سالهای بعد هم ادامه یابد

در اغلب موارد معلمان .اغلب کودکان با اختلالات رفتاری احساساتی منفی داشته و با دیگران بدرفتاری می کنند .(۲۰۱۷

علاوه بر این انزوای اجتماعی این .و همتایان آنها را طرد کرده و در نتیجه فرصتهای آموزشی مناسب را از دست میدهند

کودکان باعث بروز رفتارهای پرخاشگرانه بیشتر در آنها میشود و بنابراین مجموعه این عوامل آنها را در معرض خطر

(مولوی باسویل و ژنگ ۲۰۱۷، (بروز رفتارهای ضد اجتماعی قرار میدهد لین

۲ تعریف اختلالات رفتاری درونی سازی و برونی سازی شده تاکنون طبقه بندیهای مختلفی برای مشکلات و اختلالهای ـ۱

رفتاری کودکان صورت گرفته است طبقه بندی مشکلات دوران کودکی در قالب مشکلات درون سازی شده و

1. Salik

2. Kaiser

3. Li... %P. 4G Vos)

4T LTE1

۱۵:۱۵

:

Q

B

1_3784066676

<>

>

فصل دوم

اختلالهای برونی سازی شده و درونی سازی شده

طبقه بندی اختلال های درونی سازی شده و ،هدف کلی هدف کلی در این فصل آشنایی دانشجویان با اختلالهای رفتاری

برونی سازی شده و رابطه سبک دلبستگی را با

اختلالهای رفتاری

هدفهای یادگیری

از دانشجو انتظار میرود بعد از مطالعه این فصل بتواند

۱ اختلالهای رفتاری را تعریف کند

سبب شناسی اختلالهای درونی و برونی سازی .۲ طبقه بندی اختلالهای درونی سازی شده و برونی سازی شده را بیان کند

.شده را به صورت مختصر نام برده و رابطه سبک دلبستگی را با اختلالهای رفتاری توضیح دهد

مقدمه

در هر جامعه ای سلامت کودکان و نوجوانان از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است و تأمین بهداشت روانی به آنان کمک

لارنس و همکاران ۲۰۱۵ مک ماهون)میکند تا از نظر روانی و جسمی سالم و نقش اجتماعی خود را بهتر ایفا کنند

در بررسیهای مختلف به صورت پایدار و هماهنگ نشان داد مشکلات رفتاری در دوران (۱۹۹۴)

۰/۲۹

1. Lawrence 2. Mcmahon

اختلال های رفتاری و هیجانی

۲۶"V

%PP. 4G Vos)

AT LTE1

:

Q

B

بیش فعالی (ب

آتش افروزی (د

۱۵:۱۵

1_3784066676

اوتیسم (فوبی ج (الف

شناخت اختلالهای هیجانی و رفتاری

رشدی قرار ندارد؟-کدام یک از اختلالات زیر در گروه اختلالات عصبی

اوتیسم (ب

نافرمانی مقابله ای (د

>

یادگیری (بیش فعالی ج (الف

باید در چه سنی انجام شود؟ ADHDتشخیص اختلال DSM-5براساس .

۶ سالگی (الف

۱۰ سالگی (ج

۸ سالگی (ب

۱۲ سالگی (د

۱۰. معروف ترین مدل در زمینه اختلال نارسایی توجه بیش فعالی توسط چه کسی ارائه

بارکلي (شده است؟ الف

اینارد (ج

خودآزمایی تشریحی فصل اول

سلیگمن (آخنباخ د (ب

۱. تفاوت بین بهنجاری و نابهنجاری را توضیح دهید.

انواع اختلالهای هیجانی را نام برده و هر کدام را ۲. اختلال های رفتاری و هیجانی را از دیدگاههای مختلف توضیح دهید

اختلالهای مخرب کنترل تکانه و سلوک را توضیح دهید .به اختصار توضیح دهید.

ه. اختلال اضطراب جدایی را توضیح دهید

K%P. 4G Vos)

AT LTE1

:.

Q

B

1. tankin

Ogundele

V/3. Schroeder & Golde

<>

۲۹

1_3784066676

اختلال های برونی سازی شده و درونی سازی شده

۱۵:۱۶

>

برونی سازی شده الگوهای رفتاری سازش نایافته ای هستند که در تعارض با دیگر افراد و انتظاراتشان قرار میگیرند؛ مثل نافرمانی و تکانشگری ترال و پرینستین ،بیش فعالی ،پرخاشگری ،۱۳۹۶).

امروزه این گروه بیشتر تحت عنوان اختلالات رفتاری اخلال گرانه شناخته میشود و اختلالاتی را در برمی گیرد که در معیارهای تشخیصی خود را دارند مثل اختلال نارسایی (DSM-5)پنجمین راهنمای تشخیصی و آماری بیماریهای روانی ویژگی اصلی DSM5طبق تعریف (۲۰۱۷ ،و گایدینگاگن (توجه بیش فعالی اختلال سلوک و نافرمانی مقابله ای تاندون تشخیص اختلال کارکردی یا رفتاری برون سازی شده داشتن الگوی کرداری تکراری و پیوسته تجاوز به حقوق اولیه شیوع این مشکلات در (گنجی و گنجی ۱۳۹۷)دیگران یا تخطی از معیارها و ضوابط اجتماعی متناسب با سن است (۱۳۹۴)فرهنگهای مختلف بین ۷ تا ۲۶ درصد تخمین زده شده است ساطوریان هراتیان طهماسیان و احمدی و وایتلی (نتایج مطالعات متعدد نشان میدهند که اختلالات برونی سازی شده بیشتر به کلینیکها ارجاع داده میشوند کازدین در جمعیت های ارجاع شده به کلینیک ها میزان شیوع این اختلالت بالای ۵۰ درصد گزارش شده است؛ لذا بخش (۲۰۰۳) ۲۰۰۴ ،وانس و لوک ،لیچت هیل اسمیت،وسیعی از موارد بالینی را شامل میشوند کوستین).

مطالعه مشکلات رفتاری برونی سازی شده به چند دلیل اهمیت دارد:

نخست اینکه مشکل اولیه درصد بالایی از کوکان که به مراکز خدمات سلامت

دوم اینکه نشانه های مشکلات رفتاری برونی سازی شده به .روانی ارجاع میشوند مشکلات رفتاری برون سازی شده است

طوری که پایداری قابل توجهی طی زمان نشان میدهند و در طول تحول به شکلهای مختلفی بروز

می

کنند.

می توان گفت نشانه های درونی سازی شده در زیر نقاب رفتارهای برونی سازی

1. Externalizing Disorders

2. Trul & Prinstein

3. Disruptive Behavior Disorders

4. Tandon & Giedinghagen WO/YY S. Kazdin & Whitley

|||۱۵:۱۶

Q

B

1_3784066676 >

:

%P. 4G Vos)

4T LTE1

۱۷۵/۳۱

<>

اختلال های رفتاری و هیجانی

YA

مشکلات درونی سازی شده میتوانند بسیار زود و از سال دوم زندگی آغاز شوند

یابند پژوهشها نشان میدهند که رفتارهای درونی سازی شده پس از سال دوم زندگی به تدریج افزایش .و در طی زمان تحول

(۲۰۱۶)می یابند و در سال تا ششم زندگی به پنجم میزان قابل توجه و نگران کننده ای میرسند هانکین و همکاران دستیابی کودک .تحول توانایی های شناختی کودک علت افزایش مشکلات درونی سازی شده در طی زمان دانسته شده است به تواناییهای شناختی او را قادر می سازد تا رویدادهای منفی و اضطراب را را به یاد آورده و پیش بینی کند و یا به خیال در سالهای پیش از نوجوانی مشکلات درونی سازی شده تا اندازه ای کاهش مییابند و در .پردازی در مورد آنها بپردازد (۲۰۱۸ ،سالهای نوجوانی با افزایش مجدد آنها روبه رو میشویم اوگاندیل

اگرچه به اعتقاد برخی از پژوهشگران پایداری اختلالات درونی سازی شده در طی زمان کمتر از اختلالات برونی سازی شده است اما مطالعات متعددی حاکی از آن هستند که همچنان درصد قابل توجهی از اختلالات درونی سازی شده در طول تحول و تا سالهای بزرگ سالی پایدار میمانند و پیامدهای زیانباری برای فرد به همراه می آورند ناریوسیت و همکاران (۲۰۱۷)

نامیده می شوند شدت کمتری دارند و کودک را کمتر (سایکوتیک)این اختلالها نسبت به اختلالهایی که روان پریشی درمانده و ناتوان میسازند این گونه مشکلات بیشتر با اضطراب همراه است کودکان و نوجوانانی که جزئی این گروه فوق العاده نگرانی و ترس شدید دارند این نگرانی از چیز یا محیط به خصوصی نیست بلکه ،اختلالات قرار می گیرند بیشتر در اثر شک به توانمندی های خود است و با رفتارهای تخریبی اختلال های مربوط به خواب و ناراحتی های جسمی با این حال مشکلات درونی شده بیشتر از مشکلات بیرونی شده موجبات پریشانی و ناراحتی .مانند معده درد همراه است کودک را فراهم می آورند اختلالات درونی شده را به دو گروه کلی تقسیم میکنند اختلالهای اضطرابی و اختلالهای افسردگی اختلالات» .دومین گروه اختلالات برونی سازی شده را در برمی گیرد .(۱۳۹۶ ،شرودر و گوردن

1. Hankin

2. Ogundele

W/3. Schroeder & Golden%, 4G Vos)

AT LTE1

:

Q

B

<>

2. Kaiser

۱۵:۱۵

1_3784066676

>

اختلال های برونی سازی شده و درونی سازی شده

۲۷

ونی سازی شده از گسترده ترین و پرکاربردترین طبقه بندی اختلالهای دوران کودکی ست که از روی آورد ابعادی پیروی

(۲۰۰۱)میکند و به وسیله آخنباخ و رسکورلا

انه شده است.

۱۷۵/۳۱

(۱۹۴۰)۱ توماس ام آخنباخ -شکل ۲

اختلالات روانی کودکان و نوجوانان را به دو گروه عمدهً روان شناسان معمولا

می کنند.

اختلالات درونی سازی را در برمی گیرد؛ این مشکلات از نظر ت درون فردی هستند و به شکل کناره گیری »گروه اول

موجب آزار ،گوشه گیری تراب و افسردگی تجلی میبابند و بیش از آنکه اطرافیان را آزار دهند ،از تعاملهای اجتماعی

.(۲۰۱۷ ،ناریوسیت ن الکساندرسون و سویدبرگ)کودک میشوند و هسته اصلی آنها اختلالهای خلق یا هیجان است

1. Achenbach & Rescorla

2. Internalizing Disorders 3. Svedberg

|||XP. 40 Vos)

AT LTE1

:

3. Personality Dimensions

اختلال های رفتاری و هیجانی

۳۲

.(۲۰۱۷ ،'کابلو گایوتیرز کابو و فرناندز بروکل)باعث افزایش اختلالهای رفتاری در فرزندان شوند

در مدلی که به منظور تبیین اختلالهای درونی سازی کودکان طراحی کرده بودند مشاهده (۲۰۱۱)کرافورد و همکاران کودک عاطفه منفی مادر نقش واسطه ای دارد ،کردند در رابطه غیر مستقیم میان تنظیم هیجان اختلالهای درونی سازی تردید در تصمیم گیری و اعتماد به نفس پایین است که بر کارایی ،یکی از ویژگی های افراد دارای شخصیت نورزگرا در مطالعه ای که بر روی نوپایان هلندی و (۲۰۱۰)یامان و همکاران ،روشهای فرزندپروری اثر میگذارد در این راستا مشاهده کردند فرزند پروری ناکارآمد مهمترین پیش بینی کننده اختلالهای برونی سازی در فرزندان .مادران آنها انجام دادند است.

نتایج مطالعات متعدد نشان میدهد منفی گرایی مادر بر رفتارهای برونی سازی شده فرزند اثر می گذارد و نوجوانانی که ،یعقوب زاده جنکینز و پیلر)والدین آنها دارای شخصیت وظیفه شناس تری بودند رفتارهای برونی سازی شده کمتری داشتند شخصیت منفی مادر میتواند در رابطه بین خلق نوباوه و احتیاط اجتماعی وی در ۷ سالگی نقش واسطه ای داشته .(۲۰۱۰ باشد و نمرات پایین مادر در بعد وظیفه شناسی از ابعاد پنج گانه شخصیت پیش بینی کننده اختلالهای برونی سازی شده در .(۲۰۱۱ ،فاکان وایت و شادلر ،کابریرا)پسران است

ثبات هیجانی پدر به طور مستقیم بر .همچنین ثبات هیجانی والدین با رفتارهای برون سازی شده پسران رابطه دارد رفتارهای پرخاشگرانه کودک اثر داشته اما ثبات هیجانی مادر با میانجی گری حمایت مادرانه بر رفتارهای پرخاشگرانه .(۲۰۰۵ ،پرینزای اونگنا و هلینکس)کودک اثر دارد

1. Cabello, Gutiérrez-Cobo & Fernández-Berrocal

2. Crawford

3. Neuroticism Versus

4. Yaman

5. Maternal Negativity

6. High Conscientious

7. Jenkins & Pepler

8. Cabrera, Fagan, Wight & Schadler 9. Prinzie, Onghena & Helinchx

|||

KXP. 40 Vos)

4T LTE1

:.

a

*****, care, Crouter & Osgood

5. Sulloway

۱۵:۱۶

1_3784066676 >

اختلال های برونی سازی شده و درونی سازی شده

۳۱

فرزند اول علاوه بر پایه ریزی ارتباط با خواهر و برادر کوچکتر خود باید به کاهش توجه والدین و تغییر انتظارات آنها نیز ،کودکان بزرگتر با این احساس که والدین آنها با آمدن فرزند جدید بیشتر به امرونهی و رسیدگی به او می پردازند .پاسخ دهد .(۲۰۰۵ ،استولز و اولسون (باربر)از دستورات سرپیچی می کنند

معتقدند تولد کودک جدید با افزایش مشکلات سازش یافتگی و رفتاری در فرزندان بزرگتر مانند (۲۰۰۴)با میستر و وهس ناشی از به ،گوشه گیری پرخاشگری وابستگی و اضطراب ارتباط دارد این مشکلات از یکسو ،تغییر در کارکردهای بدنی دنیا آمدن فرزند جدید و از سوی دیگر ناشی از تغییرات به وجود آمده در رفتار والدین با فرزند بزرگتر است گرجی و

نشان داد تفاوت مهارگری والدین (۲۰۰۴)همچنین بررسی تا مروتی مکین دوباس جریس و ون آکن ۳ (۱۳۹۲)فلاحی منجر به افزایش رفتارهای

(۱۳۹۴)ساطوریان و همکاران .درونی سازی شده در دختران و برونی سازی شده در دختران و پسران خانواده میشود نشان دادند که فاصله سنی و ترتیب تولد فرزندان تأثیر معناداری بر مشکلات برونی سازی شده کودکان دارد و کودکانی که بود بیشترین میزان مشکلات برونی سازی،تفاوت سنی آنها با خواهر برادرهایشان کمتر از ۲ سال

شده را نشان دادند.

معتقد است که اختلالات برونی سازی شده نتیجه شکست در اعمال قوانین (۱۳۸۸)به نقل از بیرامی (۱۹۹۸)پاترسون قوانین بی ثبات نظارت کم و مهارتهای ضعیف حل مسئله این نوع سبک :دارای سه ویژگی هستندً والدینی هستند که معمولا فرزند پروری کودکان را به سمت نافرمانی سوق میدهد؛ به عبارت دیگر والدین کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری برونی سازی شده رفتارهای امری بیشتری دارند بیشتر مخالفت میکنند پاداشهای کمتری به رفتارهای مطیع کودک میدهند و پاداشهای ارائه شده آنها بیشتر جنبه اتفاقی دارد.

۲ ابعاد شخصیت والدین-۲-۲

ابعاد شخصیتی والدین میتوانند فرایند فرزند پروری را دچار مشکل کنند و در نتیجه

1. Barber, Stolz & Olsen

2. Baumeister & Vohs

3. Tamrouti-Makkin, Dobas, Gerris & Van Aken.

4. Patterson

5. Personality DimensionsD

XP. 40 Vos)

AT LTE1

B

2. Trul & Prinstein

3. Disruptive Behavior Disorders 4. Tandon & Giedinghagen WO/YY S. Kazdin & Whitley

1_3784066676

۱۵:۱۶

اختلال های رفتاری و هیجانی

>

۳۰

شده قرار میگیرند و موجب میشوند شناسایی و تشخیص آنچه در درون فرد میگذرد در برابر رفتارهای آشکار و اغتشاش این پدیده یعنی وقوع هم زمان .بسیار دشوار و نیازمند دقت و توجه زیاد باشد ،آمیزی که از خود به نمایش می گذارد به رغم تمایز بنیادین .اختلالات درونی سازی شده و برونی سازی شده یکی از موضوعات مورد مناقشه و بحث انگیز است ایجاد شده بین این دو گروه از نشانه ها یافته ها حاکی از آن اند که همزمانی آنها امری به نسبت رایج و بیش از آنکه یک استثنا باشد یک قانون است(لی و لیتل جونز، ۲۰۰۷).

۲ سبب شناسی اختلالهای رفتاری درونی سازی و برونی سازی شده علی رغم دانش فزاینده ای که درباره عوامل خطر -۲ ساز اختلالهای برونی سازی و درونی سازی شده وجود دارد اما هنوز نواقص و خلاهایی دیده میشود.

۲ ویژگیهای خانوادگی تولد و فاصله سنی فرزندان-۲-۱

در باب سبب شناسی این مشکلات به عوامل متعددی مانند ناتوانی والدین در مدیریت رفتار کودک و تعامل منفی والد اشاره (۲۰۰۷) ،هال کروتر و ازگل ،ترتیب تولد و فاصله سنی کیم مک ،(۲۰۱۳ ،اسنبرگ و ونگ ،زو،موتادی ،کودک جایگاه کودک از نظر ترتیب تولد یا تک فرزند بودن در شکل گیری شخصیت از بدو روان شناس مدرن مورد .شده است آدلر معتقد بود باوجود اینکه خواهر برادرها والدین یکسانی دارند و در یک خانه زندگی میکنند اما محیط .توجه بوده است های اجتماعی یکسانی ندارند و بزرگتر یا کوچکتر بودن از خواهر برادرهای دیگر و قرار داشتن در معرض بازخوردهای ،سالووی)والدین شرایط کودکی مختلفی را به وجود می آورد که در شکل گیری شخصیت مشارکت میکند ،متفاوت بدون تردید تولد فرزند جدید باعث تغییرات زیادی در نظام خانواده می شود و چه بسا بر رابطه هر یک از والدین .(۲۰۰۱ با دیگر فرزندان به ویژه فرزند بزرگتر تأثیر بگذارد.

1. Comorbidity

2. Lee & Littlejohns

3. Muhtadie, Zhou, Eisenberg & Wane٥/٣٩

<>

4G Vol)

:

Q

B

1_3784066676

١٥:١۶

>

اختلالهای برونی سازی شده و درونی سازی شده

٣٥

دل بستگی ایمن میتواند موجب افزایش جهت گیری مثبت و .مکانیسم چهارم؛ کنشوری انگیزشی در مبادلات اجتماعی است بادوام در روابط اجتماعی شود که در سطوح مختلف اجتماعی شدن دیده میشود روابط گرم و صمیمی با والدین موجب همچنین این روابط مانع از .میشود افراد با احتمال بیشتری به کنترلهای والدین تن دهند و رهنمودهای آنان را به کار گیرند ویژگی های سرشت و منش سرشت به عنوان .(٢٠٠٨)مشکلات رفتاری و انحرافهای اجتماعی میشود کاسیدی و شاور تفاوتهای فردی به نسبت پایدار در واکنش پذیری و تنظیم هیجانی توصیف میشود که با وراثت و تا حد کمی توسط تجارب تعیین میشود واکنش پذیری منفی منعکس کننده حساسیت به محرک های آزارنده ای است که پاسخهای بدنی غیرارادی و غدد درون ریز را بر می انگیزد و طیفی از

اگرچه به نظر میرسد خشم و ناکامی به .(٢٠٠۶ ،هیجانات منفی گوناگون شامل خشم و غم را ایجاد میکند رزبارت و بیتز صورت مستقیم با مشکلات برونی سازی همراه باشند اما به صورت غیر مستقیم از طریق سیستمهای نوروشیمیایی تنظیم به علاوه خشم و ناکامی میتوانند از طریق تأثیر منفی بر .کننده اضطراب و خشم با مشکلات درونی سازی نیز همراه هستند (٢٠١٣)و همکاران (روابط اجتماعی کودک باعث مشکلات درونی سازی شوند مهتادی

T

برخی مطالعات از ارتباط بین مؤلفه های مختلف سرشت و منش و مشکلات رفتاری درونی سازی برونی سازی حمایت نشان داد که همبستگی مثبتی بین صفت شخصیتی نوجویی (۲۰۱۰)مطالعه میرامورا و همکاران ،برای مثال .کرده اند بین صفت شخصیتی آسیب گریزی ،فعال سازی و رفتارهای برونی سازی و نه درونی سازی وجود دارد و از سوی دیگر) نوپایان با بازداری رفتاری بالاتر .بازداری و رفتارهای درونی سازی و نه برونی سازی همبستگی مثبت و بالایی دیده شد مشکلات درونی سازی بیشتری را در سالهای بعدی تجربه میکنند و این مشکلات تا نوجوانی ادامه دار ویلیامز و همکاران (۲۰۰۹)

مطالعه ای با ۴۱ کودک مبتلا به افسردگی اساسی و (۲۰۱۳)زاپیتلی و همکاران

1. Rothbart & Bates

2. Hiramura

3. Novelty Seeking

4. Harm Avoidance 5. Zappitelli%, 4G Vos)

IT LTE1

Q

۱۵:۱۶

1_3784066676 >

اختلال های رفتاری و هیجانی

بر اساس نظریه دلبستگی فرض شده است که مراقب اولیه کودک که پیوند دل بستگی با وی شکل میگیرد مادر است البته کودک و پدر کودک در یک دوره تحولی ولی مستقل از هم ساخته شده و ایمنی دل بستگی با دو والد -روابط دل بستگی مادر اغلب متفاوت است که نشان میدهد هر کدام از این رابطه ها توسط تعامل های خاصی شکل داده شده است گراسمن پژوهش ها نشان داده که نقش پدر در مقایسه با مادر در تربیت و فعالیتهای تربیتی .(۲۰۰۲)گراسمن وینتر و زیمرمن ، (۲۰۰۵)کودک در خانواده ها متفاوت است ویلیامز و کلی

اجتماعی منبع کنترل درونی و توانایی ،کارآمدی ،نتایج پژوهش ها نشان داد که درگیری پدر رابطه مثبتی با تحول شناختی ابراز همدلی با دیگران دارد اما عدم درگیری هیجانی پدر هر چند به طور فیزیکی حضور داشته باشد با نشانه های مرضی

.(۲۰۰۳ ،کولی)افسردگی در نوجوانان رابطه دارد

۲۰۰۵ دریافت که رابطه دل بستگی سالم میان پدر و کودک از آنها در برابر)به نقل از ویلیامز و کلی ،۱۹۹۰)رایس براساس نتایج مطالعات صورت گرفته در نظریه .مشکلات رفتاری درونی سازی شده و برونی سازی شده محافظت میکند چهار مکانیسم وجود دارد که میتواند دل بستگی را به سازش یافتگی یا سازش نایافتگی مرتبط سازد ً دل بستگی معمولا (۲۰۰۸)و شاور (کاسیدی

مکانیسم اول؛ فرایندهای نظم جویی هیجانی است که در ارتباط با دل بستگی قرار داشته و میتواند موجب شکل گیری .راهبردهای مقابله با تنیدگی شود که در سبب شناسی اختلالهای روان شناختی مطرح میشود

از هم گسیخته شناخته میشوند و می توانند راهبردهای دلبستگی ً مکانیسم دوم؛ رفتار قابل مشاهده است رفتارهایی که معمولا .خاصی باشند که برای تنظیم الگوهای ارتباطی و تربیتی والدین استفاده میشوند و هدف آنها به نوعی جلب توجه والدین است

مکانیسم سوم؛ شناخت اجتماعی است که در بازنمایی های روابط در نظریه دل بستگی مدلهای کاری نامیده میشود خود را .خشم عدم اعتماد اضطراب و ترس است،نشان میدهد در دل بستگی ناایمن این مدلها حاوی

1. Grossman, Winter & Zimmermann

2. Coley

۱۷۵/۳/۲۰۱4G Vo)

%PY. LTE1

:

Q

1_3784066676

۱۵:۱۶

>

سبک دلبستگی ۲-۲-۳

اختلالهای برونی سازی شده و درونی سازی شده

گروه نا ایمن سطوح بالاتری از .پژوهشها نشان داده که دل بستگی با آسیب شناسی روانی در نوجوانان رابطه دارد

افسردگی را نشان میدهند و در مقایسه دو گروه از کودکان ۸۰ درصد از پسرهایی که رفتار مخرب داشتند دارای دل بستگی همچنین برخی از مطالعات دیگر نقش ،ناایمن بودند در حالی که تنها ۲۸ درصد از گروه کنترل دلبستگی نا ایمن داشتند هارایون شنیت و ،رام ،پینزی)والد کودک را در تحول رفتار پرخاشگرانه نشان داده اند -فرایند ارتباطی مشکل ساز ویزمن، ۲۰۰۱).

بر طبق نظریه دلبستگی استفاده از راهبردهای کمینه کننده مانند انکار درماندگی و پذیرش یک نگرش خصمانه و دفاعی نسبت به مراقب موجب آمادگی برای اختلال های برونی سازی میشود در مقابل استفاده از راهبردهای بیشینه ساز منجر به اختلال های درونی سازی میشود؛ زیرا این کودکان به طور نیرومندی بر درماندگی خویش متمرکز شده و نیاز شدیدی له (۲۰۱۷)عشق و حمایت مراقب نشان میدهند گرانگویست و همکاران

سطوح بالاتری از ،آن دسته از کودکان و نوجوانانی که در ارتباط با والدین خود نتوانسته اند خودمختاری به دست آورند در مقابل کودکان و نوجوانانی که والدین آنها بیش از حد بر (۲۰۰۳)مارش و همکاران)افسردگی را بروز می دهند به احتمال بیشتر دچار نشانه های برونی سازی ،خودمختاری فرزندانشان تأکید کرده اند و به نوعی آنها را نادیده گرفته اند (۲۰۰۸ ،و شاور (شده مانند سوء مصرف مواد فعالیتهای غیرقانونی و رفتارهای مقابله ای میشوند کاسیدی

مطالعات متمرکز بر بررسی سهم دلبستگی در نشانگان درونی سازی شده و برونی سازی شده نشان داده اند که سبک (۲۰۱۷)دلبستگی ناایمن با سطوح بالای نگرانی رابطه داشته و برونی سازی شده را نشان میدهند گرانگویست و همکاران بیشتر مطالعات نوجوانان دارای دل بستگی ناایمن اجتنابی یا دوسوگرا سطوح بالاتری از نشانه های درونی سازی شده انجام گرفته درباره دلبستگی به والدین متمرکز بر مادران و کودکان خردسال آنها بوده و توجه اندکی به نقش پدرها شده است ویلیامز و کلی، ۲۰۰۵).

۳۷

1. Pinzi, Ram, Har-Even, Shnit & Weizman
2. Granqvist
3. Marah
4. Cassidy & Shaver
5. Williams & Kelly

|||Q

4G Vo)

۱۵:۱۶

1_3784066676

اختلال های رفتاری و هیجانی

>

۳۸

۲ آموزش رفتاری والدین-۳-۱

مداخلاتی که والدین را مورد هدف قرار میدهند از جمله روشهای مؤثر جهت پیشگیری و درمان اختلالات برونی سازی است برنامه های (BPT)والدین آموزش رفتاری والدین ،شده در کودکان میباشند از جمله رایج ترین روشهای مداخله روی موجود در این آموزش عوامل محافظتی کودکان را غنا میبخشد و عوامل خطرسازی را که با مشکلات رفتاری و عاطفی در مطالعات مختلف مورد (BPT)اثر بخشی آموزش رفتاری والدین .(۱۹۹۲) ،بارکلي)آنها ارتباط دارد کاهش میدهد و ODD ADHDاین برنامه از پشتوانه تجربی خوبی در درمان اختلالات دوران کودکی به ویژه .تأیید قرار گرفته است هدفهای زیر را دنبال میکند (BPT)برنامه آموزش رفتاری والدین (۲۰۱۶)چاکو و همکاران)کسب کرده است CD شناسایی انتظارات و آمادگی برای تغییر و درمان . (۱۹۹۲ ،بارکلی)

حل کردن مشکلات مرتبط با تکالیف درمانی .

T

تقویت تمایل به مشارکت شرکت کنندگان و افزایش تعاملات بین افراد شرکت کننده در گروه

،توسعه راهبردها در مواجهه با مشکلات زندگی علاوه بر مدیریت رفتار کودکان ارائه درمان به وسیله یادگیری آموزشی درمان گری ساخت یافته حل مسئله ،حل مسئله به وسیله الگوپردازی.

راه های حفظ تغییرات و نگهداری آنها به وسیله درمانهای خود رهنمودی استفاده از نظام های پاداش دهی برای رسیدن به .

هدفهای رفتاری در درمانگاه و خانه برای افزایش مهارتهای اجتماعی کودکان

۲ درمان شناختی رفتاری-۳-۲

ساپ و فارل اساس این روی آورد را بدین .یکی از روشهای متمرکز بر کودکان و نوجوانان درمان شناختی رفتاری است یک کودک یا نوجوان را نمیتوان به صورت (اعمال)و رفتار (هیجانات)عواطف ،(افکار)صورت شرح دادهاند شناخت مجزا رسیدگی

۵/۳۲

1. Behavior Parent Training (BPT)

2. Barkley

3. Chacko

4. Cognitive-Behavioral Therapy

|||

K<>

4G Vol

:.

Q

B

1_3784066676

۱۵:۱۶

اختلال های برونی سازی شده و درونی سازی شده

TV

همچنین عواملی چون واگذاری مسئولیت زیاد یا فعالیتهای فراوان نیز قادر است موجب .خانواده یا جامعه قرار گرفتن باشد تکمیل کننده یکدیگرند و به تنهایی ،بیماری پذیری ارثی و فشار روانی ،فشار روانی شود؛ بنابراین براساس این الگو (۱۳۹۵)کراتوچیل و موریس)نمیتوانند سبب رفتار ناهنجار شوند

۲ درمان اختلالات رفتاری برونی سازی شده و درونی سازی شده بسیاری از کودکانی که در سالهای نخستین کودکی -۳ نه تنها به سادگی از آن عبور نمیکنند بلکه ممکن است این امر تا دوران بلوغ و ،واجد مشکلات عاطفی و رفتاری هستند

حتی بزرگ سالی نیز تداوم یابد که مبتنی بر پذیرش این واقعیت است که مشکلات عاطفی و رفتاری اغلب به طور طبیعی (۲۰۱۵)کاهش نخواهد یافت و مستلزم پیشگیری و درمان هستند میلکی نوماگوچی و دنی

1. Milkie, Nomaguchi & Denny

|||

۲(۱۹۹۲) راسل بارکلی -شکل ۲

><>۷

%, 4G Vos)

AT LTE1

D

Q

۱۷۵/۳۹

3. Novelty Seeking 4. Harm Avoidance 5. Zappitelli

1_3784066676

۱۵:۱۶

>

۳۶

اختلال های رفتاری و هیجانی

۴۰ کودک سالم انجام دادند نتایج مطالعه آنها نشان داد آزمودنیهای افسرده نمرات پایین تری در صفات شخصیتی پاداش خودراهبردی و همکاری و نمرات بالاتری در آسیب گریزی و نوجویی داشتند ،پشتکار ،وابستگی.

در مطالعه خود نشان دادند کودکان مبتلا به بیش فعالی کم توجهی نمرات بالاتری در نوجویی (۲۰۱۵)ملکاری و همکاران و نمرات پایین تری در وابستگی پاداش و پشتکار دارند در حالی که کودکان مضطرب نمره بالایی در آسیب گریزی دارند و کودکان مبتلا به نافرمانی مقابله ای در مقایسه با کوکان مبتلا به بیش فعالی کم توجهی آسیب گریزی و پشتکار بالاتری دارند بیش فعالی نسبت به سایر دانشجویان نمرات /نیز نشان دادند دانشجویان مبتلا به نقص توجه (۲۰۱۵)آکباس و همکاران

پایین تری در همکاری و خودراهبری دارند

V

نیز مشخص کرد کودکانی که در ۶ سالگی به لحاظ سرشتی شرم زیادی داشتند در ۴ سال (۲۰۱۲)مطالعه ایکم و همکاران در مطالعه ای طولی کودکان را از (۲۰۰۹)کرونیز توسکانو و همکاران .بعدی مشکلات درونی سازی را نشان می دادند ۴ ماهگی تا اواسط نوجوانی بررسی کردند نتایج آنها حاکی از این بود که کودکانی که سطوح بالایی از بازداری رفتاری نشان میدهند مشکلات درونی سازی بیشتری تجربه می کردند.

فشار روانی این الگو ارتباط فعالی را بین آمادگی های ژنتیکی و دیگر عوامل زیست شناختی -نظریه بیماری پذیری ارثی کند بیماری پذیری ارثی آمادگی عوامل آسیب زایی است که زمینه .و همچنین تأثیرات عوامل فشارزای محیطی ارائه می هایی ثابت زیست شناختی و رفتارهای اختصاصی پاسخ دهی را شامل میشود؛ و فشار روانی از عوامل رایج محیطی است تعارض با همسالان از دست ،عوامل فشارزای عمومی برای نوجوانان شامل مدرسه .که میتواند موجب رفتار ناهنجار شود معشوق تصادف های جسمانی در معرض بی حرمتی،دادن

1. Reward Dependence

2. Persistence

3. Self-Directedness 4. Cooperativeness

5. Meleqari

6. Akbas 7. Eggum

|||:

%PY. LTE1

2. Rosenberg

<>

۲۱

۱۵:۱۷

1_3784066676

اختلال های برونی سازی شده و درونی سازی شده

>

این اختلالها باید دست کم در دو موقعیت متفاوت .روابط اجتماعی و سازگاری فردی تأثیر منفی بگذارد ،مراقبت از خود بروز کنند طبقه بندی مشکلات دوران کودکی در قالب مشکلات درون سازی شده و برونی سازی شده از گسترده ترین و اختلالات رفتار درونی .پرکاربردترین طبقه بندی اختلالهای دوران کودکی است که از روی آورد ابعادی پیروی می کند سازی به اختلالاتی گفته میشود که بر خود فرد متمرکز بوده و با هیجانات منفی مشخص میشوند و دربرگیرنده مشکلاتی افسردگی و شکایات جسمانی است در حالی که اختلالات رفتاری برونی سازی شده به ،اضطراب ،مانند گوشه گیری صورت تعارض با دیگران و هنجارهای اجتماعی توصیف می شود و رفتارهای قانون شکنی و رفتار پرخاشگرانه را شامل میشود.

در تحقیق بر سبب شناسی مشکلات رفتاری کودکان چندین عامل به عنوان عوامل خطرزا شناسایی شده اند که از مهمترین سبک فرزند پروری کیفیت مراقبت مادرانه صفات شخصیتی در کودک و والدین ،ترتیب تولد ،آنها میتوان به فاصله سنی از جمله روشهای درمانی در این زمینه میتوان .مشکلات زناشویی بین والدین و ثبات هیجانی اشاره کرد ،سبک دل بستگی به درمانهای دارویی آموزش رفتار والدین که مبتنی بر رویکرد رفتاری و یادگیری اجتماعی است روشهای کودک محور مانند درمان

رفتاری بازی درمانی و الگوی ارتباط همدلانه اشاره کرد -شناختی.

خود آزمایی چهارگزینه ای فصل دوم

۱. تشخیص افتراقی بین اختلال رفتاری درونی سازی شده با اختلالات روان پریشی در دوران کودکی و نوجوانی شامل کدام گزینه است؟

الف) تعداد نشانه ها

ب) سن بروز نشانه ها

ج) شدت نشانه ها

د) توصیف نشانه ها

۲) در رابطه با اختلال های رفتاری درونی سازی شده کدام گزینه زیر نادرست است؟ الف. اغلب با اضطراب همراه هستند

ب هسته اصلی این اختلالات مشکلات خلقی است.

محدود به دوران کودکی بوده و اثر ندانی در بزرگسالی (د .تحول تواناییهای شناختی از علل افزایش این اختلالات است (ج

ندارند.

۳۵

|||

>4G Vol

۱۵:۱۷

Q

B

1_3784066676

۵/۴۳

>

اختلال های رفتاری و هیجانی

بازی ابراز محبت و رفتاری مشابه سایر اعضای گروه میکند فرهادی دوست زاده و

<>

سبزی، ۱۳۹۵).

۳(۲۰۱۵-۱۹۳۹) مارشال بی روزنبرگ -شکل ۲

الگوی ارتباط بدون خشونت روزنبرگ رفتارهای محبت آمیز با کودکان را در .الگوی ارتباط همدلانه و بدون خشونت

کودکان پرورش ارتباط ،بهترین شیوه مهار پرخاشگری و کاهش خشونت در ،به باور وی .دستور کار خود قرار میدهد

ارتباط همدلانه و غیر خشونت آمیز یکی از توانایی های هیجانی مهم است که .همدلانه بدون خشونت و محبت آمیز است

نشانه ها و نمودهای آن از اوایل کودکی آغاز

می شود.

خلاصه فصل دوم

اختلال های رفتاری به شرایطی گفته میشود که پاسخهای هیجانی و رفتاری فرد در مدرسه با هنجارهای سنی فرهنگی و قومی در تناقض باشد و بر عملکرد تحصیلی

1. Non-Violent Communication Program ۵/۴۴2. Rosenberg

|||۴۲

۴۳

4G Vol

:

Q

B

1_3784066676

۱۵:۱۶

>

اختلال های برونی سازی شده و درونی سازی شده

بی

۳۹

این روی آورد مداخله با دسته ای از روشها مشخص میشود که در آنها تأکید بر .زیرا آنها فرایندهای همپوش هستند ،کرد کودکان و نوجوانان .تنظیم درونی رفتار است مداخلات در سطح فردی شامل آموزش مهارت اجتماعی و حل مسئله است تحت آموزش تکنیکهای رفتاری و شناختی قرار گرفته و راهبردهایی که برای حل مسئله فردی مفید هستند را می آموزند خشم مهارتهای کنار آمدن و ابراز ،برنامه آموزش مهارتهای اجتماعی ترکیبی مهارت های حل مسئله مهارتهای کنترل (۲۰۱۶)وجود است کاتوین و همکاران

"

نتایج مطالعات متعدد حاکی از اثر بخشی درمان شناختی رفتاری بر کاهش مشکلات مرتبط با اضطراب رفتارهای لانگ و ژنگ ،وو)گوشه گیری و انزوای اجتماعی و اختلال نافرمانی مقابله ای بوده است ،پرخاشگرانه اختلال سلوک

(۲۰۱۶)

۲ بازی درمانی-۳-۳

یک روش درمانی مناسب برای کودکان ۳ تا ۹ ،بازی درمانی در سطح جهانی رو به تزاید است بازی درمانی»محبوبیت استفاده از فعالیتها و :بازی درمانی را این گونه تعریف کرده است ،فرهنگ توصیفی انجمن روان شناسی آمریکا .ساله است نقاشی و رنگ انگشتی در روان درمانی ،عروسکها عروسک خیمه شب بازی،آب مکعب ،مثل گل سفالگری)وسایل بازی کودک

رفتار خود را تغییر میدهند تمنای پذیرش از رابطه ،بازی درمانی بر این فرض استوار است که کودکان در مقابل پذیرش سرچشمه می گیرد رابطه ای که با ارضا کردن نیازهای کودک محبت و تأیید را در (یا جانشین او)مطلوب اولیه با مادر گروه درمانی داشتن عطش اجتماعی یعنی نیاز به پذیرش و »وجود او ثبت و ضبط میکند شرط اساسی پذیرفته شدن در است کودک حاضر است در ازای پذیرش همتایان .مقبولیت در نزد همتایان و میل به کسب پایگاه و حفظ حرمت در گروه شروع به ،تکانه های خود را اصلاح و رفتار خود را تغییر دهد کودک در صورت پذیرفته شدن

1. Chatwin

2. Wu

3. Group Play Therapy

4. American Psychological Association

5. Acceptance

6. Peers%PY. LTE1

3. Hyperkinetic Reacu

4. Minimal Brain Dysfunction

5. Behavioral Inhibition

6. Douglas

7. Saito

TV

اختلال نارسایی توجه بیش فعالی

1_3784066676

۱۵:۱۷

>

،پابلانو)برای آن معرفی شده است ADHDC)و مرکب (1-ADHD)..بی توجهی غالب (ADHD-H)فکری غالب

.(۲۰۱۴ ،لیونا و راینوسو

ًتقریبا

هیچ

آن

در این .توجه متخصصان معلمان و والدین را به خود جلب نکرده است ADHDاختلال دیگری در دوران کودکی به اندازه در کودکان ۹ تا ۱۷ ساله اهل ADHDزمینه همسانی بین فرهنگی از طریق تحقیق و با شناسایی خصیصه های مشابه از شایع ترین اختلال های روانی است که در کودکان تشخیص داده میشود؛ این ADHD .پورتوریکو تأیید شده است علاوه بر درصد قابل .اختلال ۳۰ تا ۴۰ درصد تمام موارد ارجاعی به کلینیک های راهنمایی کودک را شامل میشود به طور مشخص ADHDافراد مبتلا به .ملاحظه ای از ارجاع های اخیر به مراکز درمان بزرگ سالان را تشکیل میدهد نشانه هایی را ظاهر میسازند که میتوان آنها را به عنوان نشانه های مربوط به فقدان توجه نشانه های مربوط به بیش فعالی ترکیبی از این دو گروه نشانه ها ظاهر میسازند؛ ADHDافراد مبتلا به ًغالبا،تکانش کری یا ترکیب آنها گروه بندی کرد .مبتلا هستند توصیف میشوند (ADHDبنابراین به عنوان افرادی که به نوع مرکب

مشهودتر است آنها ممکن است در ،اختلال تمرکز در این کودکان در کارهایی که فعالیت دائم و جدی مغزی را لازم دارد تماشای تلویزیون بازی با کامپیوتر و فعالیتهای لذت بخش با کودکان دیگر تفاوتی نداشته باشند ولی در کارهایی که فعالیت .مداوم مغزی و تمرکز لازم دارد انجام تکالیف درسی تفاوت آنها با کودکان دیگر نمایان میشود

یعنی در انتخاب توجه به اطلاعات ضروری و بی ،به نظر میرسد مغز آنها اطلاعات محیطی را بیش از حد لازم میگیرد رعایت قوانین منزل و مدرسه برای آنان مشکل است و برای پیروی از .توجهی به اطلاعات غیر ضروری ضعف دارند قوانین توجه بیشتری لازم دارند در انجام تکالیف مدرسه تمرکز روی درس رعایت قوانین مدرسه و داشتن روابط اجتماعی

.(سعیدی؛۱۳۹۱)مناسب با همکلاسیها مشکل دارند برای رسیدن به هدفهای دراز مدت برنامه ریزی نمیکنند

<>

1. Poblano

2. Cross-Cultural Consistency

3. Combined Type

|||۵/۴۸

4G Vol

:.

Q

B

1_3784066676

اختلال های رفتاری و هیجانی

۱۵:۱۷

>

۴۶

۳ اختلال نارسایی توجه بیش فعالی-۱

-

در .است (ADHD)اختلال نارسایی توجه بیش فعالی .تشخیص داد ًتعریف و توصیف یکی از اختلالات روانی که عموما این ا دسته اختلالات عصبی رشدی قرار گرفته که کودکان پیش دبستانی نوجوانان و بزرگ سالان سراسر جهان 5-DSM را مبتلا کرده و مشخصه آن الگو پایدار توجه و افزایش تکانشگری و بیش فعالی است ملاک های تشخیه این اختلال ظرف می افزاید مجادله هایی هستند که بر ADHDپیچیدگی در شناختن .چند دهه گذشته به طور قابل ملاحظه ای تغییر کرده اند بیش فعالی شاید رایج ترین یا همگانی ترین واژه به کار .(۲۰۱۶ ،اوسامی)س علتها روند و درمان آن صورت گرفته اند رفته برای نوعی روان شناختی در دوران کودکی است سایر اصطلاحاتی که متخصصان برای آن

و

اختلال

ٔنارسایی کنشی جزئی مغز نارسایی توجه؛ اما در حال حاضر آنچه رسما ،به کار برده اند عبارت اند از پرجنب وجوشی

اختلال ناشی از ضعف در بازداری رفتاری است و سه خصیصه ،اختلال نارسایی توجه و بیش فعالی نامیده می شود

درجاتی از کم توجهی که با سطح رشد کودک نامتناسب است تکانشگری و بیش فعالی و پیدایش قبل از هفت :اساسی دارد

رفتارهایی است که از DSM-5ویژگی اصلی این اختلال در .(۱۳۹۳، ۱۹۹۵ به نقل از کندال ،سالگی داگلاس و بیکر

این موقعیتهای اجتماعی .لحاظ اجتماعی ناسازگار میباشند و باید قبل از ۱۲ سالگی و حداقل در دو محیط مستقل اتفاق بیفتند

میتوانند خانواده مدرسه و یا هر جای دیگری باشند که در آنجا غیر از کودک فرد دیگری نیز حضور دارد رفتارهای

از آنجا که اکثر افراد .(۲۰۱۵ ،سایاتو)شدیدتر از آن هستند که از سن کودک انتظار میرود ADHDاخلالگرانه کودکان

بیش فعالی دارند اما در بعضی افراد یکی بر دیگری غلبه دارد؛ لذا سه ،هم نشانه های بی توجهی و هم ADHDمبتلا به

نوع فرعی بیش فعالی بی

1. Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD)

2. Usami

3. Hyperkinetic Reaction

4. Minimal Brain Dysfunction

5. Behavioral Inhibition

6. Douglas

/ 7. Saito۱۵:۱۷

4G Vos)

%PY. LTE1

1_3784066676

<>

فصل سوم

>

هدف کلی

اختلال نارسایی توجه بیش فعالی

ADHDعلت و روشهای درمان ،(ADHD)هدف کلی در این فصل آشنایی با تعریف اختلال نارسایی توجه بیش فعالی

است.

هدفهای یادگیری

از دانشجویان انتظار میرود پس از مطالعه و یادگیری محتوای این فصل بتوانند ۱ اختلال نارسایی توجه بیش فعالی

(ADHD) را نام برده به صورت مختصر توضیح ADHDبرای اختلال 5-DSMمعیارهای . .را تعریف کنند

دهند.

تشخیص دهد کودکان مبتلا به نارسایی توجهی بیش فعالی چه کسانی هستند؟

. علت نارسایی توجه بیش فعالی چیست؟

د. ADHDروش های درمان را توضیح دهند.

مقدمه

ابتدا تعریفی ارائه میشود سپس علائم و نشانه های .در این فصل در مورد اختلال نارسایی توجه بیش فعالی بحث خواهد شد

بررسی خواهد شد؛ به علل 5-DSMآن براساس

سیر اختلال و درمان آن پرداخته خواهد شد ،اختلال.

|||%, 4G Vos)

AT LTE1

D

Q

1_3784066676

۱۵:۱۷

>

.(۲۰۱۸ ،دارد که به طور عمده ویژگیهای بی توجهی را نشان دهند اسمیت و لانگبری

1. Langberg

۵/۵۲

۵۰

اختلالهای رفتاری و هیجانی

البته با برخی تفاوت فرهنگی)نوع فرهنگ عامل بروز این اختلال نیست زیرا در گروه های نژادی و فرهنگهای مختلف در مناطق مختلف به طور عمده ناشی از ADHDبه نظر میرسد که تفاوت های موجود در میزان شیوع .دیده میشود آن تفاوت ،روشهای تشخیصی و روش شناختی باشند با این حال شاید در نگرشها نسبت به رفتارهای کودکان یا تعبیرهای پایین تر از ،میزان شناسایی بالینی در ایالات متحده برای جمعیت های آمریکایی لاتینی .فرهنگی نیز وجود داشته باشد ارزیابیهای نشانه توسط منبع خبر میتواند تحت تأثیر گروه فرهنگی کودک و منبع خبر قرار .جمعیتهای سفید پوست است (۲۰۱۳)مربوط هستند انجمن روانشناسی آمریکا ADHDداشته باشند بدین معنی که رسوم فرهنگی مناسب در ارزیابی گاهی علائم در .بین ۱۲ تا ۲۰ سالگی رخ میدهد و بهبودی قبل از ۱۲ سالگی نادر استً بهبودی در صورت وقوع معمولا (بلوغ بهبودیافته و گاهی نیز تا بزرگسالی ادامه می یابد هانوریو انتو و همکاران ۲۰۱۸

با افزایش سن پرتحرکی کمتر شده ولی اختلال تمرکز و رفتارهای ناگهانی می تواند باقی بماند در ۱۵ تا ۲۰ درصد موارد میتوانند با علائم خود ADHDبدون درمان تنها یک سوم تا نصف کودکان دچار .علائم همراه با افزایش سن ادامه می یابد بزرگ سالان مبتلا به (سعیدی ۱۳۹۱)در زندگی سازگار و منطبق باشند و بقیه مستعد بروز مشکلات ثانویه خواهند بود به سختی میتوانند برنامه ریزی کنند در مدیریت کردن زمان و پول بینظم هستند و کامل ،در زندگی روزمره خود ADHD بزرگسالی بیشتر ،مردان به خصوص در طول .کردن تکالیف تحصیلی یا به سامان رساندن تکالیف شغلی را دشوار میدانند (فرناندز و همکاران ۲۰۱۸ ،میگولز)در معرض خطر تصادفات اتومبیل قرار دارند و جریمه های رانندگی دریافت میکنند از کودک چهار ساله انتظار نمی رود که ًتوانایی کودکان برای توجه انتخابی با بالا رفتن سن بهبود می یابد؛ مثلاً مطمئنا ممکن .مهارتهای تمرکز توجه کودک ۱۲ ساله را داشته باشد

غلط

اما ،است تکانشگری کودک در بدو ورود به مدرسه شش سالگی به صورت پاسخ سریع و به مسائل ریاضی آشکار شود

۱۹۹۳ به نقل از کندال ،بارگی کاران)نوجه ی گر بیشتر ممکن است که تکانشگری را به صورت ایجاد حوادث بروز دهد (۱۳۹۳)

|||۲۹

4G Vol

D

Q

B

1_3784066676

اختلال نارسایی توجه بیش فعالی

۱۵:۱۷

>

.سقف دهان و پائین بودن ارتفاع گوشها گاهی گوشها یک تا دو انحراف استاندارد پائین تر از متوسط مردم عادی هستند

،نیستند ADHDحرکتی یا اجتماع مخصوص ،زبان ،تأخیرهای خفیف در رشد

ولی اغلب روی میدهند ویژگیهای مرتبط میتوانند شامل تحمل کم ناکام تحریک پذیری یا تغییر پذیری خلق باشند حتی در غیاب اختلال یادگیری خاص عملکر تحصیلی یا شغلی اغلب معیوب است رفتار بی توجهی با انواع فرایندهای شناختی یا حافظه مشکلاتی را نشان ،ممکن است در آزمونهای توجه عملکرد اجرایی ADHDاساسی ارتباط دارد و افراد مبتلا به دهند هر چند که این آزمونها به قدر کافی حساس یا اختصاصی نیستند که وظیفه شاخصهای تشخیصی را داشته باشند در یا مصرف ،سلوک ،با خطر بیشتر اقدام به خودکشی به طور عمده زمانی که با اختلالات خلقی ADHDاوایل بزرگسالی (۲۰۱۳)مواد هم زمان باشد ارتباط دارد انجمن روانشناسی آمریکا

۳ شیوع و سیر اختلال-۳

اولین فعالیت حرکتی مفرط را مشاهده ،خیلی از والدین هنگامی که کودک نوپاست .متنوع است ADHDسیر اختلال اغلب در طول ADHDقبل از ۴ سالگی دشوار است ،میکنند اما متمایز کردن نشانه ها از رفتارهای هنجاری بسیار متغیر این اختلال در طول اوایل .سالهای مدرسه ابتدایی تشخیص داده میشود و بی توجهی برجسته تر و معیوب تر میشود

بزرگسالی به نسبت پایدار است اما برخی افراد روندی بدتر همراه با پرورش رفتارهای ضداجتماعی دارند در اغلب افراد نشانه های بیش فعالی حرکتی در نوجوانی و بزرگ سالی کمتر واضح میشوند اما مشکلات در رابطه با ADHDمبتلا به درصد قابل ملاحظه ای از کودکان مبتلا به .بیقراری بی توجهی برنامه ریزی نامناسب و تکانشگری ادامه می یابند ADHD (۲۰۱۳)تا بزرگسالی به نسبت معیوب می مانند انجمن روانشناسی آمریکا

ADHD ۲ به ۱ و در بزرگ سالان ً در کل جمعیت در پسرها شایعتر از دخترهاست طوری که میزان آن در کودکان تقریبا ،دخترها بیشتر از پسرها احتمال دارد که به طور عمده ۸ویژگیهای بی تو ا نشان دهند اسمیت و لانگبرگ .۶ به ۱ است ۲۰۱۸).

1. Langberg0/01

<>

%, 4G Vos)

AT LTE1

:

Q

۱۵:۱۷

1_3784066676 >

اختلال های رفتاری و هیجانی

TA

۳ ویژگی های تشخیصی-۲

الگوی مداوم بی توجهی و اینا (ADHD)بیش فعالی /ویژگی اصلی اختلال کاستی توجه

از لحاظ رفتاری به ADHD :بی توجهی .بیش فعالی تکانشگری است که در عملکرد با رشد اختلال ایجاد می کنند صورت پرت شدن از تکلیف نداشتن پشتکار مشکل شمری ماندن و نامنظم بودن آشکار میشود و ناشی از لجبازی یا فقدان بیش فعالی به .درک نیست

مفرط تلنگر زدن یا ،فعالیت حرکتی بیش از حد نظیر اینکه کودک به اطراف میدود در زمانی که نامناسب یا وول خوردن

پرحرفی اشاره دارد در بزرگسالان بیش فعالی می تواند به صورت بیقراری شدید یا منحرف کردن دیگران از فعالیتشان آشکار شوید تکانشگری به اعمال عجولانه ای اشاره دارد که به صورت لحظه ای بدون دوراندیشی اراک میدهند و به جست زدن در خیابان بدون نگاه کردن تکانش گری میتواند میل به پاداشهای فوری با (احتمال زیاد به فرد لطمه میزنند مثل مثل)ناتوانی در به تعویق افتادن خشنوسی یا لذت را منعکس کند رفتارهای تکانشی میتوانند به صورت مزاحمت اجتماعی یا گرفتن تصمیمات مهم بدون در نظر گرفتن پیامدهای بلند مدت آشکار شود /دیگران و)یحد مزاحمت بیش از حد برای ،مثل گرفتن یک کار بدون اطلاعات کافی جلوه های این اختلال باید در بیش از یک موقعیت وجود داشته باشند اعلا در خانه بدون مشورت با منابع خبر که فرد را در ً مدرسه و محل کار تأیید نشانه های قابل ملاحظه در موقعیت های مختلف معمولا عداوت ،نشانه ها بسته به زمینه در موقعیتی خاص ًمعمولا .این موقعیت ها دیده اند نمی توانند به صورت دقیق انجام شود باشد به ،بگیرد تحت نظارت دقیق باشد در موقعیت تازه ،در صورتی که فرد برای رفتار مناسب پاداشهای مکرر .دارند یا در ،از طریق صفحه های نمایش الکترونیک ًمثلا)فعالیتهای خیلی جالب بپردازد تحریک بیرونی مستمر داشته باشد علائم این اختلال می توانند خیلی کم (در دفتر متخصص بالینی (ًمثلا)موقعیت های تک سنگ در حال تعامل کردن باشد علائم چهره ای ظاهری ندارند اما ADHDافراد مبتلا به (۲۰۱۳)باشند یا وجود نداشته باشند انجمن روانشناسی آمریکا فراوانی عصر نابهنجاریهای خفیف نابهنجاریهای ملایم در این افراد ممکن است اندکی بیشتر از افراد سالم باشد مثل هایپر PT. 4G Vos)فاصله زیاد بین دو چشم گودی بیش از حد)تلوریسم

4T LTE1

:

Q

B

or

<>

اختلال نارسایی توجه بیش فعالی

۱۵:۱۸

1_3784066676

>

برای مثال آزمون جور کردن چهره های)تصویر دیگر نشان داده میشود و تنها یکی از آنها با تصویر استاندارد جور است این کودکان به .تکلیف کودک پیدا کردن یکی از شش عکسی است که با شکل استاندارد جور باشد .(۲۰۰۱ ،آشنای کیگان چنین موقعیتی که ابهام پاسخ در آن زیاد است با تکانشگری و تأخیر اندی در پاسخ دهی و خطای فراوان واکنش نشان .میدهند گویا بدون بررسی دقیق احتمال های دیگر عجولانه به حدس زدن روی می آورند

در پژوهشی معلوم شد که عملکرد در تکلیف جور کردن براساس نمونه

(۱۳۹۳)۱۹۸۱ به نقل از کندال ،آزمونی ۲۵ ماده ای برای شناسایی کودکان بیش فعال مفید است هماتیدیس کانستانتاریس اکثر روشهای سنجش ارزیابی این اختلال ترکیبی از فنون جمع آوری داده ها را به کار میبرند تا ببینند که آیا کودک (۱۳۹۳)ملاکهای مورد نیاز برای این تشخیص را دارد یا خیر به نقل از کندال

،با کاهش عملکرد تحصیلی و پیشرفت تحصیلی ADHDبیش فعالی /۳ پیامدهای کارکردی اختلال کاستی توجه -۳-۳ پیشرفت و حضور شغلی ضعیفتر احتمال بالاتر بیکاری و تعارض میان ،و در بزرگ سالان با عملکرد ،طرد اجتماعی خود احتمال دارد در نوجوانی به ADHDخیلی بیشتر از همسالان بدون ADHDفردی بالا ارتباط دارد کودکان مبتلا به اختلال سلوک و در بزرگسالی به اختلال مصرف مواد در آینده دچار شوند به خصوص در صورتی که اختلال سلوک یا بیشتر از همسالان احتمال دارد که صدمه ببینند ADHDافراد مبتلا به .باشد.اختلال شخصیت ضداجتماعی پرورش یافته

تصادفات و تخلفات در رانندگان مبتلا به

زیاد است انجمن ADHDشایع ترند احتمال وجود چاقی در افراد مبتلا به ADHD

(۲۰۱۳)روانشناسی آمریکا

انجام دادن نامناسب یا تغییر تکالیفی که نیازمند تلاش مستمر هستند اغلب توسط دیگران به صورت تنبلی بی مسئولیتی یا روابط خانوادگی .عدم همکاری تعبیر میشود

1. Matching Familiar Figures Test
2. Kagan
3. Short Latency
4. Homatidis

5. Konstantarcas

|||

>D

XP. 4G Vos)

Q

++ LTE1

۷۵/۵۴

<>

۱۵:۱۷

3. Neurodevelopmental Disorders

1_3784066676

4. Disruptive, Impulse- Control, And Conduct Disorders

>

۵۲

اختلال های رفتاری و هیجانی

علاوه بر اینکه نمیتوانند آرام بنشینند و به ADHDمدارس به ترکیبی از عوامل آموزشی ویژه نیاز دارند کودکان مبتلا به درس توجه کنند ممکن است انواع رفتارهای اخلالگرانه مختل کننده نشان دهند که باعث ناراحتی معلم و همکلاسیها میشوند (ایمبودون و فهر، ۲۰۱۸).

۳ شیوه های تشخیص-۳-۲

درجه بندی رفتار توسط والدین و . :برای شناسایی آن در کودکان لازم است چند ارزیابی و سنجش جداگانه صورت گیرد (کانرز سیتارینوز پارکر واپشتاین ،معلمان فهرست درجه بندی والدین مانند مقیاسهای درجه بندی کانرز کانرز ۱۹۹۵؛ (دُی پاول و همکاران ۱۹۹۴ به نقل از کندال)بیش فعالی نسخه خانگی –و مقیاس درجه بندی کم توجهی (۱۹۹۸ ،۱۳۸۹) مصاحبه با کودک والدین و معلمان جزئیات رفتار کودک یا موقعیت اجتماعی را که ممکن است در مقیاسهای درجه بندی .

به ویژه ،در این راستا مصاحبه با والدین و معلمان مفید است .نادیده گرفته شوند میتوان از طریق مصاحبه به دست آورد برای ارزیابی ثبات رفتار کودک در موقعیتهای مختلف و شناسایی شرایطی که رفتار مشکل زا را تشدید یا تضعیف نمونه گاهی حضور برخی همکلاسان یا ترتیب خاص نشستن در کلاس ممکن است با تشدید نشانه های ،کنند برای .می کودک مبتلا در کلاس مرتبط باشد.

.

برای مثال .مشاهده مستقیم رفتار و انجام تکلیف مشاهده کودک اطلاعات ارزشمندی برای ارزیابی اختلال فراهم می آورد ایذایی کودکان بیش فعال را از کودکان غیر ،تعلیم دیده میتوانند به کمک مشاهده و ثبت رفتارهای مزاحم و ِمشاهده گران مثالی از انجام تکلیف یک مسئله جور کردن براساس نمونه است که در .بیش فعال به صورت قابل اطمینانی متمایز سازند آن یک تصویر استاندارد در بالای شش

1. Imboden

2. Conners

3. Sitarenios

4. Parker

5. Epstein

6. Dupaul

7. Match-To-Sample

|||4G Vol

D

Q

B

1_3784066676

1. Honnorio

2. Miguelez

اختلال نارسایی توجه بیش فعالی

۱۵:۱۷

>

در نیمی از کودکان مبتلا و بنا به اظهار برخی در سه چهارم آنان مشکلات تمرکز توجه و مشکلات تحصیلی و ً تقریبا
.و چه بسا به صورت بالقوه تا بزرگسالی ادامه می یابد (۱۳۹۳ ،کندال)اجتماعی مربوط به آن تا نوجوانی

به این اختلال مبتلا بودهاند بر بعضی مشکلات تحصیلی و ً جوانانی که قبلا ً یک گزارش پی گیری جدید نشان داد که ظاهرا قضایی که در دوره دبیرستان با آن درگیر بودند غلبه میکنند اما همچنان اختلالات روان شناختی خود را عامل این مشکلات (۱۳۹۳)میدانند و تقاضایشان برای دریافت خدمات بهداشت روانی ادامه می یابد هانسن و همکاران ۱۹۹۹ به نقل از کندال

ً با پی گیری پسربچه های مبتلا پس از چهار سال یعنی هنگام ورود آنان به دوره نوجوانی بررسی ویژگیهایی که احتمالا آسیب آشکار به عملکرد اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال سلوک و .میتواند مشکلات آتی را پیش بینی کند ممکن شد اختلالات توجه و بزهکاری دوران ،با این حال طبق تحقیقی در نیوزلند .مصرف مواد مخدر در این پسران میانجامد (۱۳۹۳)نوجوانی با مصرف مواد مخدر مرتبط نبود فرگوسن و همکاران ۱۹۹۷ به نقل از کندال

1

در حال حاضر در زمینه معنادار بودن پیش بینیهای مرتبط با این اختلال و اعتبار ادعای کاهش این اختلال با بالا رفتن سن (۱۳۹۳)تونی و همکاران ۱۹۹۷ به نقل از کندال)بحث های زیادی وجود دارد

در چه طبقه ای از کودکان استثنایی ADHDدر چه طبقه ای قرار میگیرند؟ کودکان مبتلا به ۳ADHD کودکان -۳-۱ اختلالات عصبی رشدی دارند و از طرف دیگر نشانه های کودکان مبتلا به ً قرار میگیرند؟ از یک طرف آنها ظاهرا را هم در فصل اختلالات ADHDاختلال 5-DSM ،اختلالات هیجانی و رفتاری را نیز نشان میدهند به همین دلیل .امیال و سلوک آورده است -رشدی و هم در فصل اختلالات مختل کننده کنترل -عصبی

T

اما یک واقعیت مشخص شده است این کودکان برای داشتن تجربه خوب در

1. Juvenile Offending

2. Fergusson

3. Neurodevelopmental Disorders

4. Disruptive, Impulse- Control, And Conduct Disorders

|||:

4G Vos)

1_3784066676

۱۵:۱۸

>

۵۶

اختلالهای رفتاری و هیجانی

همکاران ،۱۹۷۷ به نقل از ها مفورد و ،واتر)به آن دچار نشدند ،کودکانی که دچار صدمات مغزی قطعی و محرز بودند شایویتز و)نیز در آشکار ساختن تفاوتهای کالبدی مغز (CAT)۱۳۹۶ استفاده از تصاویر توموگرافی محوری رایانه ای زامتکین و همکاران)و تفاوتهای سوخت و ساز مغزی (۱۳۹۶)همکاران ،۱۹۸۳ به نقل از ها مفورد و ،همکاران این یافته ها به نتیجه گیری انجامید که صدمه .میان کودکان مبتلا و کودکان گروه گواه غیر مبتلا ناموفق بودند (۱۹۹۳) اما (۱۳۹۳)علت انحصاری کم توجهی نیست و حتی ممکن است از همبسته های آن نیز نباشد به نقل از کندال ً مغزی قطعا ظریف ،دستخوش آسیب شده است و عملکرد آنها در تکالیف ،کارکرد مغزی کودکان مبتلا ً بررسیها نشان میدهند که احتمالا و در مقیاسهای گوش به زنگی و کنترل تکانه به خوبی (۱۳۹۳)نقایصی دارد برای مثال آگوست ۱۹۸۷ به نقل از کندال عده ای بخشهای خاصی از مغز مانند (عمل نمیکنند برای مثال هماتیدس و کانستانتاریس ۱۹۸۱ به نقل از کندال ۱۳۹۳ به تأخیر زمانی ،خوانده می شود «نارسایی عصب شناختی»مناطق پیشانی و پیشانی لیمبیک را در آن دخیل میدانند و آنچه فعالیت نارس ،کودکان مبتلا EEGتوجه رفتار اجتماعی و حتی الگوهای ،و کندی نسبت به همسالان اشاره دارد دامنه مغزی را مطرح میکنند هر چند نتایج پژوهشی با فرضیه دخالت کارکرد مغز در این اختلال سازگار است اما عملکرد ضعیف در اجرای تکالیف و کارکردهای تأخیری میتواند ناشی از عوامل دیگری باشد.

آیا خورد و خوراک ممکن است باعث بروز این اختلال شود؟ بر طبق این فرضیه بیش فعالی با ترجیح غذای کودک مانند

غیر ً با این حال این نظر که مصرف زیاد مواد قندی به کم توجهی منجر میشود کاملا .مصرف زیاد مواد قندی ارتباط دارد در سبب شناسی اختلال نارسایی توجه و بیش فعالی تأثیر مصرف غذاهای حاوی رنگهای مصنوعی .واقعی قلمداد می شود

یعنی پس از انتشار ،و مواد نگه دارنده غذایی بر این اختلال نیز تأیید نشده است؛ اما از اوایل تا اواسط دهه ۱۹۷۰

ادعاهایی مبنی بر اینکه تغییر برنامه

غذایی می تواند منجر به کاهش بیش فعالی شود والدین مشتاقانه برنامه های غذایی خود را عوض کردند و همزمان

دانشمندان آزمون دقیق فرضیه رژیم غذایی را در دستور کار

خود قرار دادند.

۵۹

1. Computerized Axial Tomography Scans

2. Shaywitz

3. Zametkin

4G Vol

% 1.4 LTE

۱۵:۱۸

1_3784066676 >

0/9.

1. Swanson 2. Kinsbourne

اختلال های رفتاری و هیجانی

ج) عوامل عصبی شیمیایی تغییراتی در مواد شیمیایی ناقلهای عصبی مغز به شانهای بیش فعالی نسبت داده شده اند.

د خلق وخو بیش فعالی و میدان توجه نامحدود گاهی به دلیل محرومیتهای میجانی در کودکان پرورشگاهی دیده میشود که با

رفع عوامل محرومیت از بین

می روند

رژیم غذایی به رغم نظریه هایی که در سالهای پیش ارائه می شد مبنی اینکه چاشنیها و رنگهای مصنوعی و افزودنیهای (

مطالعات اخیر هیچ ،خوراکی و شکر در تشدید علائم بیش فعالی نقش دارند و باید از رژیم غذایی کودک مبتلا حذف شوند

آلرژی و آسم در مطالعات سازمان (و .گونه ارتباطی بین نشانه های این بیماری و رژیم غذایی و افزودنیها پیدا نکرده اند

یافته شواهدی مبنی بر ارتباط این اختلال

با آلرژی و آسم نشان نداده است.

هستند ADHDرفتاری مؤثرترین روشهای درمانی برای کمک به کودکان مبتلا به ،داروهای محرک و آموزش.

-

استفاده از داروست داروهایی که میتوانند از سرعت کودک ADHDداروهای محرک یکی از درمانهای احتمالی برای

داروهایی ً معمولا .بکاهند تا معلم یا دیگران بتوانند توجه او را به مدت کافی به خود جلب کنند و مطالب لازم را بیاموزند

یعنی کنترل کودک ،تجویز میشوند و نتایج دلخواه را نیز به همراه می آورند "دکستر و آمفتامین و پمولین ،مثل متیل فنیدیت

اکثر والدین از دادن داروهای اینچنین قوی به کودک خردسال خود اکراه دارند ولی در اکثر .بر رفتارش را افزایش میدهند

(۱۳۹۲ ،ساراسون و ساراسون)مواقع رفتار غیر قابل کنترل کودکان آنها را وادار میکند که تسلیم شوند

تنکس دو داروی دیگر هستند که پزشکان متخصص گاهی استفاده از آنها را به خصوص)کاتاپرس و گوان فاسین)کلونیدین

ADHDبرای کودکان مبتلا به

1. Methyphenidate
2. Dextroamphetamine
3. Pemoline
4. Clonidine
5. Catapres
6. Guanfacine
7. Tenex

=

|||

K

O4G Vo1) L

%. LTE1

:

۱۵:۱۸

1_3784066676

اختلال های رفتاری و هیجانی

>

Of

میتواند با اختلاف و تعاملهای منفی توصیف شود روابط با همسالان اغلب به خاطر طرد همسالان یا دست انداختن فرد مبتلا ضعیفتر و نمرات ،کمتر پیشرفت شغلی ،به طور متوسط تحصیلات ADHDافراد مبتلا به .مختل میشود ADHDبه این اختلال در حالت شدید به .هوش بالاتر از همسالان خود دارند هر چند که در این زمینه ها تغییر پذیری زیاد وجود دارد طور محسوسی مختل کننده است و بر سازگاری اجتماعی خانوادگی تحصیلی شغلی تأثیر میگذارد انجمن روانشناسی آمریکا، ۲۰۱۳).

مدرسه و بی توجهی همسالان با نشانه های برجسته بی توجهی ارتباط زیاد دارند ،تحصیلی مشکلات مرتبط با ،کمبودهای صدمه ناشی از تصادف در رابطه با نشانه های برجسته بیش فعالی یا ،کمتر،در حالی که طرد همسالان و به درجات تکانشگری

محسوس ترند.

سبب شناسی و درمان در حال حاضر علل نارسایی توجه بیش فعالی ناشناخته است علت واحدی برای این اختلال وجود مواد سمی و عوامل ،پیش زمینه ژنتیکی نقص و آسیب مغزی تغذیه .ندارد بلکه عوامل متعددی در پیدایش آن مؤثرند تحقیقات چه .(۱۳۹۲ ،ساراسون،و (محیطی همه در این امر دخیل اند ساراسون

می گویند؟

توارث پذیری .بالاتر است ADHDدر خویشاوندان تنی درجه یک افراد مبتلا به ADHDژنتیکی و فیزیولوژیکی همبستگی دارند عوامل علیتی ضروری و کافی نیستند ADHDدر حالی که ژنهای خاصی با .قابل توجه است ADHD.

اختلالات بینایی و شنوایی نابهنجاریهای سوخت و ساز اختلالات خواب کمبودهای غذایی و صرع به عنوان تأثیرات ممکن هر چند که میزان ،یا ویژگی های جسمانی خاص ارتباط ندارد ADHD .باید در نظر گرفته شوند ADHDبر نشانگان کام بسیار قوس دار گوشهای پایین قرار گرفته ممکن است ،نابهنجاریهای جسمانی جزئی مثل افزایش فاصله دو عضو بدن ۲۰۱۳ ،به نسبت بالا باشد انجمن روانشناسی آمریکا).

احتمال اینکه هر دو جفت دوقلوهای یک .شواهدی وجود دارد که نشان میدهد عوامل ژنتیکی در این اختلال نقش دارند ۸۱ درصد و ،تخمکی دچار این اختلال شوند

(کلی ۲۰۱۸)در دوقلوهای دو تخمکی تنها ۲۹ درصد است

۵/۵۷

=

|||

O% 46

++ LTE1

۵۷

اختلال نارسایی توجه بیش فعالی

۱۵:۱۸

1_3784066676

>

اما به طور کلی نتوانستند از این فرضیه حمایت کنند که رژیم ،بود،شواهد جمع آوری شده تا حدی دو پهلو ،در مجموع بیش فعالی داشته باشد سوانسون و کینزبورن -غذایی یا اصلاح رژیم غذایی میتواند تأثیر قابل توجهی بر کم توجهی تحقیقات دقیق تر آنها نشان داد که رژیم .پس از بازنگری چندین بررسی به نتایج بسیار آموزنده ای دست یافتند (۱۹۸۰) غذایی تأثیر چندانی در این امر ندارد.

برخی محققان عوامل اجتماعی و محیطی و به ویژه ناموفق بودن کودک در یادگیری مهارتهای شناختی و رفتاری را از علل محیط شاید رفتارهای مربوط به این اختلال را نیز مانند رفتارهای بهنجار مناسب اجتماعی یا به طور .این اختلال میدانند

بسامان مشاهده رفتارهای نامناسب ،فقدان محیط یادگیری (۱۳۹۳ ،به نقل از کندال (شکل دهد اولیری ۱۹۸۰ «رفتار»کلی

اطرافیان پاداش گرفتن برای حدس زدن،

و

تعلیم ندیدن در مورد راهکارهای شناختی ساماندهی توجه و به هم ریختگی آشفتگی محیط خانه میتواند در ناموفق ،سریع برای مثال والر و داماس بسیاری از اختلالات دوران کودکی را نتیجه .بودن کودک برای کنترل کافی خود نقش داشته باشند تعاملات مختل والد کودک دانسته اند؛ اما به طور کلی در زمینه عوامل محیط اجتماعی که در علت کم توجهی مطرح هستند والدین دستورات و ،داده ها نشان میدهند که والدین کودکان مبتلا نسبت به سایر .تحقیقات اندکی صورت گرفته است آن .سرپرستی مستقیم تری اعمال میکنند اما به نظر میرسد این اعمال بیشتر برآیند و نتیجه رفتار کودک است تا علت همچنین در پی استفاده مؤثر از داروهای محرک الگوی کنترل مادران کمرنگ تر میشود بارکلی و همکاران ۱۹۸۵ به نقل (۱۳۹۳ ،از کندال

بنابراین علل بیش فعالی به صورت خلاصه عبارت اند از:

(الف عوامل ژنتیک همگامی بالا در دوقلوهای یک تخمکی نسبت به دوقلوهای دو تخمکی و اینکه خطر ابتلا در خواهران .و برادران کودکان بیش فعال نسبت به کودکان دیگر بیشتر است

ب آسیب مغزی اگر در دوران جنینی و اوایل شیرخوارگی آسیبی به مغز برسد می تواند در شکل گیری این اختلال مؤثر باشد با استفاده از دستگاه انسفالوگرام میتوان

1. Swanson 2. Kinsbourne

=

|||

.صدمات مغزی را شناسایی کرد

اختلال های رفتاری و هیجانی

۵۸4G Vol

%. LTE1

۱۵:۱۸

1_3784066676 >

:

۵/۶۲

اختلال های رفتاری و هیجانی

9.

شود این بخش اصول عمده رفتار درمانی و شناخت درمانی را که روی هم رفته مبنای درمانهای .رفتار درمانی تأکید می را تشکیل میدهند مورد بررسی قرار میدهد در اصول عمده رفتار درمانی بر این نکته ADHDروان شناختی مؤثر برای نظریه های شناختی بر انواع تفکرات ،تأکید میشود که پاداش و تقویت چگونه بر رفتار تأثیر میگذارند از طرف دیگر رویکردهای رفتاری رفتار درمانی رفتارهای خاص را .مربوط به وقایع و چگونگی تأثیر آنها بر اعمال تأکید می کنند در درمان بر رفتارهای خاص مانند .هدف قرار میدهد و کوشش می کند تا با استفاده از اصول تقویت آنها را تغییر دهد قسمت عمده نظریه ای را که پشتوانه رفتار درمانی است .ترک کردن صندلی و صحبت کردن به طور مناسب تأکید میشود رفتار و پیامدها ،خلاصه کرد یعنی پیشایندها A-B-Cمیتوان با توالی

اما اینکه رفتار افزایش یابد یا ثابت بماند یا .برای وقوع رفتار برخی پیشایندها شرایط محرکها باید رفتار را فراخوانی کنند احساسات ،خود را با افکار درونیً کاهش نشان دهد به پیامدهایی که به دنبال رفتار میآیند بستگی دارد رفتار درمانی معمولا اینکه آیا کودک یک پیامد خاص را دوست دارد یا دوست .یا انگیزشها درگیر نمیسازد بلکه خود رفتار حائز اهمیت است ندارد به اندازه این احتمال که آیا رفتار دوباره روی خواهد داد اهمیت ندارد

رفتاری افزایش یا کاهش فراوانی یک رفتار خاص را با تغییر پیامدها،این اصول

1. Behavior Therapy

2. Cognitive Therapy 3. Antecedents

4. Consequences

5. Positive Reinforcement

6. Negative Reinforcement

7. Punishment

8. Extinction

۱۵/۶۳

=

K

مدنظر قرار میدهند

تقویت مثبت .

تقویت منفی

تنبیه .

خاموش سازی

محروم سازی% 46 Vo ++ LTE1

۱۵:۱۸

1_3784066676

>

اختلال های رفتاری و هیجانی

۶۲

خانوادگی طلاق و ،دوم محیط آشفته خانواده های دارای وضعیت اقتصادی و اجتماعی پایین می تواند بالاتر بودن بی ثباتی اختلالات روان شناختی والدین را توجیه کند؛

و بالاخره اینکه فراوانی این اختلال در میان کودکان طبقه اجتماعی و اقتصادی پایین ممکن است ناشی از تمایل بعضی (۱۳۹۳ ،کندال)معلمان و اطرافیان برای دیدن رفتار کم توجهی بیش فعالی در این کودکان باشد

خواه این روابط با همسر باشد یا با همکار فردی ،مشکلات جدی در روابط دارندً معمولا ADHDبزرگ سالان مبتلا به آشنا یا حتی غریبه آنها همیشه جویای تحریک هستند ممکن است با تحریک کردن تعارضها در تعاملهای خود با دیگران به ، این کار را ،یا اصرار اینکه آنها باید حرف آخر را بزنند ،وسیله شروع کردن جروبحثها امتناع از خاتمه دادن به جروبحثها

انجام دهند.

آنها گوش دادن به دیگران را مشکل میدانند ممکن است فقط قسمتهایی از یک گفت و گو را بشنوند مستعد قطع کردن گفت و کنند آنها خیلی حساس یا کوک هستند که در گرایش .گو هستند و در حالی که دیگران سعی دارند صحبت کنند صحبت می .آنها به حساسیت زیاد و واکنش پذیری مفرط آشکار است و در مواقع طغیانهای خشم و دمدمی بودن شدید ابراز میشود گری تصمیم گیری نامناسب و مدیریت بی منطق آنها در زمینه مالی عصبانی میشوند به خاطر ،همسران آنها از تکانش مزمن گم کردن کلیدها و اقلام مهم دیگر و عدم قابلیت اطمینان کلی آنها ،نشانه های بی نظمی فراموش کاری دیر کردن .تعارضها و جر و بحث هایی ایجاد میشوند

است نوعی اختلال عصبی رشدی که الگوی بادوام بی توجهی و یا ،خلاصه فصل سوم اختلال نارسایی توجه بیش فعالی علائم چهره ای ظاهری ندارند اما فراوانی بعضی نابهنجاریهای خفیف ADHDشود افراد مبتلا به .بیش فعالی را شامل می علت واحدی برای .نابهنجاریهای ملایم در این افراد ممکن است اندکی بیشتر از افراد سالم باشد

/al. Troubled Environment

۶۳

اختلال نارسایی توجه بیش فعالی

=

>4G Vol)

%TY. LTE1

:

Q

۱۵:۱۸

1_3784066676 >

اختلال نارسایی توجه بیش فعالی

۶۱

برای تغییر دادن ً رویکرد شناختی رفتاری نظریه های شناختی بیشتر بر افکار متمرکز هستند و اصول تقویت را صرفا

مورد تأکید قرار میدهند این نظریه ها بر نقشی که گفتار درونی در جهت تنظیم ADHDافکار و شناختهای مربوط به رفتار ایفا میکند تأکید می کند.

.

برای مثال کودکی که قبل از رسیدن نوبتش در .تحریف شده میتوانند موجب بدرفتاری فرد شوند»و «غیر منطقی»افکار بازی وارد میشود با خود فکر میکند که دیگران زیاد بازی میکنند و این عادلانه نیست تغییر دادن افکار یا خود گویی کودک به چیزی واقعی تر مانند میدانم که بیقراری میکنم من باید منتظر نوبت بمانم به کنترل رفتار او کمک خواهد کرد مصطفائی (۱۳۹۵)و امین پور

هدفهای درمان شناختی شامل افزایش توانایی مراجع در حل مسئله و بازبینی رفتار خود میباشند مداخلات شناختی برای درمان ADHDغالبا ً در ارتباط با راهبردهای رفتاری مورد استفاده قرار می گیرند.

کمتر احتمال دارد رفتارهای مخاطره آمیزی را که در مردان ADHDجنسیت زنان مبتلا به .نارسایی توجه بیش فعالی و گری و بی توجهی را ،ملالت مشکلات سازمان دهی تکانش ،در عوض آنها به احتمال بیشتری .دیده میشود نشان دهند درصد کمی از بزرگ .ویژگیهایی که اگر در فرزند پروری اختلال ایجاد کنند مایه نگرانی زیاد است ،تجربه می کنند میتوانند انرژی اضافی و بی قراری خود را به فعالیتهای خلاق هدایت کنند هر چند که ناتوانی آنها ADHDسالان مبتلا به در حفظ کردن توجه و تعهد نسبت به یک پروژه ممکن است احتمال موفق شدن آنها را برای طولانی محدود کند.

اگرچه این کودکان هم شهری و روستایی و هم از خانواده های ثروتمند و فقیر هستند ولی در این میان تفاوتهای اجتماعی و اقتصادی نیز گزارش میشود .اول اینکه تعداد کودکان مبتلا در طبقات طی ً اقتصادی پایین تر احتمالا -چندین تبیین احتمالی مطرح است مادران طبقة اجتماعی .پایین کمی بیشتر است،اجتماعی دوران حاملگی تغذیه و مراقبت کمتری دارند و به همین میزان مشکلات بارداری در میان آنان بیشتر است و شاید همین امور بر رشد مغز جنین اثر می گذارد.

۱۷۵/۶۴

1. Time Out

=

>4G Vol)

%TY. LTE1

۵۵

ها

Q

اختلال نارسایی توجه بیش فعالی

۱۵:۱۸

1_3784066676 >

به ویژه زمانی که والدین نیز سابقه ،خواهران و برادران شخص مبتلا بیشتر در معرض خطر ابتلا به این اختلال هستند میان ژن ناقل دوپامین و این اختلال رابطه مشاهده شده است؛ و حداقل یک بررسی ،در چندین بررسی .ابتلا به آن را دارند گری در مقایسه با نشانه های نارسایی توجه روابط قوی تری را گزارش کرده است ،برای نشانه های بیش فعالی تکانش (گیوین و مک نیکلسون ۲۰۱۸

-

میرساند اما اغلب ADHDخطر دو یا سه برابر را برای (محیطی وزن خیلی کم به هنگام تولد کمتر از ۱۵۰۰ گرم با سیگار کشیدن در طول حاملگی ADHDگرچه .نمی شوند ADHDدچار ،کودکانی که وزن کم به هنگام تولد دارند همبستگی دارد اما مقداری از این ارتباط بیانگر خط ژنتیکی متداول است موارد کمی ممکن است با واکنش به جنبه هایی از غفلت جا دادنهای پرورشی متعدد مواجهه با سم ،رژیم غذایی ارتباط داشته باشند امکان دارد که پیشینه بهره کشی از کودک مواجه با مواد سمی محیطی با .یا مواجه با الکل در رحم وجود داشته باشد ،(مثل التهاب مغز)عفونتها ،(مثل سرب)عصبی (۲۰۱۳)آینده همبستگی داشته است اما معلوم نیست که آیا این ارتباطها علیتی باشند انجمن روانشناسی آمریکا ADHD

/۵۸

۳ خلق و خوبی-۳-۲

پرزحمت یا محدودیت؛ تهییج پذیری منفی؛ و یا تازگی طلبی بالا ارتباط دارد ،رفتاری کنترل ،با کاهش بازداری ADHD ADHDاین صفات میتوانند برخی از کودکان را برای

آسیب مغزی کودک در این میان چه نقشی (۲۰۱۳)آماده کنند ولی منحصر به این اختلال نیستند انجمن روانشناسی آمریکا چند .دارد؟ محققان احتمال نقش صدمهٔ مغزی کر کاری مغز و نارسایی عصب شناختی را در این اختلال بررسی کرده اند دهه قبل برای رفتارهایی که در حال حاضر نارسایی توجهی بیش فعالی گفته

.صدمه جزئی مغزه استفاده می شد»میشوند از عنوان

اما اکثر نتایج این رابطه را تأیید ،عنوان مشتاق اثبات ارتباط میان صدمه مغزی و این اختلال بودند،محققان هماهنگ با این در پژوهشهای مربوط به بیماران مبتلا معلوم شد که تنها ۵ تا ۱۰ درصد آنها سوابق مطرح صدمه مغزی دارند و .نکردند اکثر

1. Gavin

2. Neurological Immaturity

=

≍

اختلال های رفتاری و هیجانی

۵۶1% 46 Vo

+ LTE1

Q

۱۵:۱۸

1_3784066676 >

اختلال نارسایی توجه بیش فعالی

۵۹

.توصیه میکنند ،که تیک هم دارند یا کودکان پرخاشگر انفجاری و تحریک پذیر و کسانی که به سختی می خوابند

واکنش این کودکان به داروها چه مثبت باشد و چه منفی آنها باز هم به یک برنامه آموزشی ویژه نیاز خواهند داشت زیرا وقتی به طور دائم و به شدت مشغول فعالیتهای فیزیکی هستند معلمان یا والدین خود را خسته می کنند و بسیاری از تجربه .های درسی مهم را از دست میدهند

روان مهمترین داروهای،گفته شد داروهای محرک ً همان طور که قبلا

داروهایی که در حال حاضر مورد استفاده قرار .هستند ADHDمورد استفاده برای درمان

:میگیرند عبارت اند از

. متیل فنیدیت

. دکستر و آمفتامین

.

"یمولین

تگرتول کارباترول و کلونوپین موقعی استفاده میشود که مصرف داروهای دیگر نتیجه ،داروهای ضد تشنج مانند دپاکوت شواهد موجود برای .مطلوبی را ارائه نمی دهند یا اینکه الگوی پرخاشگری و تحریک پذیری شدیدی در رفتار وجود دارد متعددی اثر بخشی ،مطالعات پژوهشی .اثربخشی این داروها خیلی کم است و اثرات جانبی آنها میتواند قابل ملاحظه باشد مؤید ،نقد و بررسیهای انجام شده از این پژوهشها .نشان داده اند ADHDداروهای محرک را برای کودکان مبتلا به نشان میدهند که داروها در کاهش انواع رفتارهای مشکل آفرین مؤثرند اثرات ً این مطالعات معمولا .سودمندی آنها میباشند بسیار بیشتر از اثرانشان بر مشکلات شناختی یا عملکرد تحصیلی است ً آنها بر رفتار آشکار معمولا.

. درمانهای روان شناختی

رویکردهای رفتاری و شناختی به تازگی متخصصان بالینی چند نوع نظریه رفتاری و شناختی را برای درک و درمان بر حذف رفتارهای ناخواسته و اکتساب رفتارهای جدید با استفاده از اصول ،در این رویکردها .مطرح کرده اند ADHD یادگیری اجتماعی و

۷۵/۶۲

1. Methyphenidate 2. Dextroamphetamine

3. Pemoline

=

|||

O۶۹

1% 46 Vo

+ LTE1

Q

اختلالات اضطرابی

۱۵:۱۸

1_3784066676 >

شکایت های جسمی مانند سردرد شکم درد و یا خستگی به پزشک مراقبتهای اولیه مراجعه میکنند از آنجایی که این کودکان رفتارهای نابهنجار کمتری دارند و درواقع به نظر میرسد که تمایل به خشنود کردن دیگران دارند مشکلاتشان به راحتی توسط

اضطراب نیز همان چهار مؤلفه ترس را (۱۳۹۷ ،والدین معلمین و پزشکان نادیده گرفته میشود کی مونتگمری و مونسن دارد ولی با یک تفاوت مهم مؤلفه شناختی ترس انتظار خطری واضح و به خصوص است در حالی که مؤلفه شناختی در ترس فکر معمول این است که دسگ ممکن است مرا گاز بگیرد در مقابل در .انتظار خطری مبهم است ،اضطراب اختلال اضطراب فراگیر فکر معمول این است که اتفاق وحشتناکی ممکن است برای خانواده ام بیفتد مؤلفه بدنی اضطراب مانند ترس

تشویش و ورم معده ،عناصر هیجانی اضطراب نیز همانند ترس است دله وحشت .عناصر واکنش اضطراری :است اینکه مؤلفههای رفتاری اضطراب نیز هما ترس است جنگ و گریز فراخوانده میشوند؛ اما موضوعی که فرد ،بالاخره مبتلا از آن بگریزد یا اجتناب کند یا علیه آن باید پرخاشگری نشان دهد از وضوح کمتری برخوردار بوده و گاهی اوقات حال آنکه اضطراب براساس خطر مبهم استوار .مبهم است؛ بنابراین ترس بر پایه واقعیت یا مبالغه خطر واقعی قرار دارد سیستم ترس در خدمت پاسخ جنگ یا گریز است و برای حفاظت از انسان .(۱۳۹۶ ،باچر و همکاران)است طراحی شده است.

اجتناب می تواند به صورتی آشکار بروز کند مانند .اضطراب اجتناب از موقعیت یا شیء ترساننده است،شایع ترین پی آمد هرگز رانندگی نمیکنند یا هرگز در حضور جمع صحبت نمی کنند ،اینکه برخی افراد هرگز به مغازه های بزرگ نمی روند. زبان بیخوابی ،می تواند باعث لکنت ً میتواند بر رفتار تأثیر منفی بگذارد و به عملکرد آسیب رساند مثلا ً اضطراب مستقیما

،شایع ترین اختلال رفتاری ناشی از اضطراب اجتناب یا گریز است باچر و همکاران .پرتحرکی و رفتارهای تکراری شود

گفته شد ً همان طور که قبلا .اختلالات اضطرابی جزء طبقه اختلالهای درونی سازی شده محسوب می شوند (۱۳۹۶

،کمرویی،افسردگی ،مشکلات و اختلالات درونی سازی شده بیشتر متوجه خود فرد هستند تا دیگران اضطراب گوشه گیری

و هراس نمونه هایی از

1. Withdrawal

=SA

59

:

4G Vo3)

1% LTE1

۱۵:۱۸

1_3784066676 >

فصل چهارم

اختلالات اضطرابی

هدف کلی

هدف کلی این است تا خواننده کتاب و دانشجویان گرامی با اختلالات اضطرابی ویژگی های اصلی و انواع آن فوبیها و

.اختلال وحشت زدگی آشنا شوند

هدف های یادگیری

توضیح دهند ویژگیهای اصلی .از دانشجویان انتظار میرود که پس از مطالعه و یادگیری محتوای این فصل بتواند

توضیح دهند اختلال وحشت .ویژگیهای بالینی فوبیهای خاص و اجتماعی را شرح دهند .اختلالات اضطرابی کدم اند؟

زدگی چه ویژگیهای بالینی دارد؟

.جنبه های بالینی اختلال اضطراب فراگیر را شرح دهند

توضیح دهند اختلالات اضطرابی چگونه درمان میشوند؟

سعی کرد هوشیار باقی بماند .هاله احساس کرد سرش گیج میرود و به این نتیجه رسید که لحظاتی بعد بیهوش خواهد شد گویی از خودش فاصله گرفته بود انگار که خودش نبود دلش هم درد گرفت آن قدر هم شدید بود که گویی میخواهد منفجر احساس دل به هم خوردگی شدید میکرد ضربان قلبش به قدری تند شده بود که گویی از درون به قفسه سینه اش ضربه .شود میزدخواست نفس عمیقی فروکشد اما کار به شدت دشواری مینمود با آنکه دهانش خشک بود همه بدنش را داند رق پوشانده دستهایش بی اراده او ست حرفی بزند اما هر چه کرد کلمه ای و بدنش به هر سو تکان میخور .بود

می لرزیدند

=

O4G Vol)

%TY. LTE1

Q

۱۵:۱۸

1_3784066676 >

اختلال های رفتاری و هیجانی

حالا تنها فکری که در ذهنش دور میزد این بود که مرگش فرارسیده .از دهانش خارج نشد

است.

شاید بتوان گفت نشانه نزدیک شدن حمله قلبی است و شاید هم آپاندیسیت .آنچه خواندید نشانه های یک ناخوشی شدید است .حاد این احتمال هم هست که بیمار تحت تأثیر محرکی خارجی که تولید اضطراب شدید کرده به این حال و روز افتاده باشد

مقدمه

اجتماعی ویژگیهای ،ویژگیهای بالینی فوبی های خاص و ،در این فصل در خصوص ویژگیهای اصلی اختلالات اضطرابی .اختلال وحشت زدگی جنبههای بالینی اختلال اضطراب فراگیر و نحوه درمان این اختلالات مباحثی مطرح شده است

- اختلالات اضطرابی در کودکان و نوجوانان

- بررسیهای اخیر نشان .تعریف و توصیف اختلالات اضطرابی از جمله شایع ترین اختلالات روان پزشکی جامعه است لااقل ،داده است که اختلالات اضطرابی دارای بیشترین فراوانی در سطح کل جمعیت است به طوری که از هر چهار نفر

به علاوه مطالعات نشان (سادوک و روئیزه ۱۳۹۵ ،یکی واجد معیارهای تشخیصی یک اختلال اضطرابی است سادوک داده است که اختلالات اضطرابی باعث بروز بیماریهای متعدد استفاده زیاد از خدمات مراقبت بهداشتی و اختلالات ۲۰۱۷ ،میشل و ویدکیند ،باندلو)کارکردی می شود.

اختلالات اضطرابی شامل اختلالاتی هستند که ترس و ناراحتی زیاد و رفتارهای پر هرج و مرج در آنها رایج است و در (۲۰۱۴)شوتلورث و هوبر ،چاپمن)واقع پیش بینی کننده وقوع یک تهدید در آینده هستند

کودکان مبتلا به اختلالات اضطرابی ناراحتی ،باوجود اینکه همه افراد در بعضی از مواقع اضطراب را تجربه می کنند بسیار شدید و پایداری را تجربه کرده و این اضطراب عملکرد روزمره آنها را به طرز قابل ملاحظه ای مختل می کند.

نگران توصیف میشوند ولی اغلب با»کودکان مبتلا به اختلالات اضطرابی اغلب تحت عنوان افراد

1. Bandelow

2. Chapman

三

>99

:

%. LTE1

4G Vo1) L

9. Troubled Environment

۱۵:۱۸

1_3784066676 >

پیش زمینه ژنتیکی نقص و آسیب مغزی تغذیه مواد سمی .این اختلال وجود ندارد بلکه عوامل متعددی در پیدایش آن مؤثرند برای شناسایی آن در کودکان لازم است چند ارزیابی و سنجش جداگانه صورت .و عوامل محیطی همه در این امر دخیل اند می گیرد درجه بندی رفتار توسط والدین و معلمان مصاحبه با کودک والدین و معلمان و مشاهده مستقیم رفتار و انجام تکلیف با برخی تفاوت فرهنگی (فرهنگ عامل بروز این اختلال نیست زیرا در گروههای نژادی و فرهنگهای مختلف البته،نوع

دیده می شود.

ژنتیکی نقص و آسیب ،پیش زمینه .علت واحدی برای این اختلال وجود ندارد بلکه عوامل متعددی در پیدایش آن مؤثرند تغذیه مواد سمی و عوامل محیطی همه در این امر دخیل اند،مغزی ،.

استفاده از داروست داروهایی که میتوانند از سرعت کودک بکاهند تا معلم یا ADHDیکی از درمانهای احتمالی برای دیگران بتوانند توجه او را به مدت کافی به خود جلب کنند و مطالب لازم را بیاموزند متخصصان بالینی چند نوع نظریه مطرح کرده اند در این رویکردها بر حذف رفتارهای ناخواسته و ADHDرفتاری و شناختی را برای درک و درمان اکتساب رفتارهای جدید با استفاده از اصول یادگیری اجتماعی و رفتار درمانی تأکید می شود.

خود آزمایی چهارگزینه ای فصل سوم

۱ کدام گزینه مربوط به اختلال نارسایی توجه بیش فعالی نیست؟.

ناسازگاری از لحاظ اجتماعی (الف)

شروع قبل از ۱۲ سالگی (ب

وجود حداقل دو نشانه طی ۶ ماه (بروز نشانه اختلال حداقل در دو محیط متفاوت د (ج

باوجود ADHDحداقل مدت زمان لازم برای تشخیص 5-DSMمطابق با معیارهای

۶ نشانه یا بیشتر در کودک کدام است؟

۱۲ ماه (الف

۳ ماه (ج

ب ۶ ماه

۱ ماه (د

=4G Vol)

%TY. LTE1

Q

۱۵:۱۹

1_3784066676 >

اگر .مدارک مستندتر با مطالعه روی دو قلوهای تک تخمکی به دست می آید که از شرایط ژنتیکی مشابهی برخوردارند یکی از این دوقلوها با اختلال اضطراب روبه رو شود امکان اینکه دوقلوی دیگر به همان اختلال اضطرابی مبتلا شود ۳۱ اگر بخواهیم مقایسه ای کرده باشیم دوقلوهای دو تخمکی با دوقلوهای همراه که ژنهایشان مشابه .تا ۸۸ درصد است خواهران و برادرانی است که در زمانهای مختلف به دنیا آمده اند با امکان بسیار کمتری به بیماری اضطراب مشابه مبتلا اگر یکی از قلهای همزاد به اختلال اضطراب دچار شود امکان اینکه قل دیگر همان اختلال اضطرابی را پیدا کند .میشوند صفر تا ۳۸ درصد است.

داشتن ساختار ژنتیکی مشابه سبب میشود که امکان بروز اختلال اضطرابی با فوبیا اگر در یکی از دوقلوها وجود داشته جالب اینجاست که دوقلوهای همزاد در مقایسه با .باشد در دیگری به احتمال دو برابر یا بیشتر صورت خارجی پیدا کند این نشان می دهد که اگر دو کودک .سایر برادرها و خواهرها ۸ تا ۱۰ درصد بیشتر با اختلال اضطراب روبه رو میشوند تحت سرپرستی پدر و مادر واحدی در یک خانه بزرگ شوند اگر یکی از دوقلوها با اختلال اضطراب روبه رو شود دیگری به نظر میرسد که هم طبیعت و هم .هم تحت تأثیر رفتار پدر و مادر به احتمال بیشتری به اختلال اضطراب دچار میشود پرورش نقشی در مضطرب شدن بازی میکنند

حملات وحشت ،چه چیزی به ارث میرسد؟ با توجه به علم و اطلاعی که در حال حاضر وجود دارد کسی فوبیای اجتماعی و اگورافوبیا را از پدر و مادرش به ارث نمی برد اما به نظر میرسد که تیپ شخصیتی هر کسی میتواند سبب شود که او به والدینی که مضطرب هستند در مقایسه با والدینی که اضطراب ندارند به احتمال بیشتری صاحب .شدت تشویق پیدا کند وقتی با شخصیت به شدت واکنشی متولد میشوید ممکن است آمادگی .فرزندانی میشوند که اختلال اضطرابی پیدا میکنند زیادی برای اضطراب پیدا کردن داشته باشید که این بستگی به شرایط محیطی و طرز تربیت و نشو و نمای شما دارد.

برای مثال اینکه شما گرفتار اگورافوبیا یا فوبیای اجتماعی شده باشید بستگی به این دارد که تا چه اندازه آموختید که وقتی با ماهیت ،کنید خجالت بکشید اینکه گرفتار حملات وحشت بشوید یا نشوید،میخواهید برنامه ای را در حضور دیگران اجرا اینکه در حالی که شرایط ،جان کلام .بستگی دارد ،و شدت استرسی که در کودکی و نوجوانی در معرض آن قرار گرفتید موروثی ممکن است سبب شود شما با نظام

=

|||

O4G Vo1) L %. LTE1

۱۵:۱۹

1_3784066676 >

۷۰

اختلال های رفتاری و هیجانی

اختلالات زیر در دسته اختلالات اضطرابی DSM-5در (۱۳۹۶)همکاران ،و (رفتار درونی سازی شده هستند هاردمن ،فوبی اجتماعی اختلال وحشت زدگی ،انتخابی فوبی خاص (سکوت)لالی ،قرار میگیرند اختلال اضطراب جدایی اختلال اضطراب :آگورافوبیا و بسیاری از اختلالات اضطرابی میتوانند در دوران کودکی تظاهر کنند که عبارت اند از اختلالات اضطرابی به طور شایع در خانواده ها وجود .جدایی اختلال پانیک یا هراس اختلال اضطرابی منتشر و فوبیاها دارند اغلب کودکان مبتلا به اختلالات .بنابراین اغلب پزشکان در می یابند که کودکان مضطرب والدین مضطرب ،دارد کمبود اعتماد به نفس ملال و افزایش حساسیت به سرزنش ،اضطرابی یک سری علائم مانند خجالت دوری گزینی اجتماعی یا طرد شدن را تجربه میکنند حداقل یک سوم از کودکان مبتلا به اختلالات اضطرابی دارای معیارهای دو یا سه اختلال (۱۳۸۶)اضطرابی به صورت همزمان میباشند کی و همکاران

اضطراب و یا هر دو را در طول زندگی خود تجربه ،اضطراب و تفاوت بین آنها در عمل تمامی کودکان ترس ،۴ ترس-۲ دستخوش تغییرات بدنی و هیجانی گوناگون ،همه ما ترس را تجربه کرده ایم هنگامی که خطر را تجربه میکنیم .می کنند .ترس چیزی نیست جز یک احساس و هیجان که آنها را در ذهن خود می پرورانیم .میشویم که پاسخ ترس را تشکیل میدهند

پاسخ ترس دارای چهار عنصر است

.الف عناصر شناختی انتظار آسیب قریب الوقوع

خطر به علاوه تغییرات موجود در،ب عناصر بدنی واکنش اضطراری بدن به

.ظاهر ما

عناصر هیجانی احساسهای دلهره و وحشت و وحشت زدگی (ج

عناصر رفتاری جنگ و گریز (د

1. Separation Anxiety Disorder

2. Selective Mutism.

3. Specific Phobia

4. Social Anxiety Disorde

5. Panic Disorder

6. Agoraphobia

7. Fear

VI

اختلالات اضطرابی

=% 4G Vo

++ LTE1

ه:

w7v. rear

۷۱

اختلالات اضطرابی

۱۵:۱۹

1_3784066676

>

و ولف ۲۰۱۹ (ترس یک واکنش بی درنگ و هشدار دهنده به خطر موجود یا تهدیدهای اضطراری زندگی است ماش ناشناخته که به فرد دست میدهد ،ناخوشایند و مبهم هراس و دلواپسی با منشأ ،اضطراب عبارت است از یک احساس منتشر اضطراب بر عملکرد شناختی اثر گذاشته و موجب .و شامل عدم اطمینان درماندگی و برانگیختگی فیزیولوژی است تحریفهای ادراکی میشود

وجه افتراق آن از ترس این است که ترس پاسخ متناسبی به یک تهدید شناخته شده است؛ در صورتی که اضطراب پاسخ به تعداد ،کودکان محتوی ترس آنها نیز تغیر میکند،تهدیدی است که ناشناخته متعارض است با بزرگ شدن مبهم یا

اضطراب نیز همان چهار مؤلفه ترس .(۱۳۹۷ ،ترس های آنها افزایش یافته و ترس آنها پیچیده تر میشود کی و همکاران را دارد ولی با یک تفاوت مهم مؤلفه شناختی ترس انتظار خطری واضح و به خصوص است در حالی که مؤلفه شناختی ترس فکر معمول این است که سگ ممکن است مرا گاز بگیرد در مقابل در ،است در .اضطراب انتظار خطری مبهم فراگیر فکر معمول این است که اتفاق وحشتناکی ممکن است برای خانواده ام بیفتد مؤلفه بدنی اضطراب ،اختلال اضطراب تشویش و ورم ،مانند ترس است عناصر واکنش اضطراری عناصر هیجانی اضطراب نیز همانند ترس است دلهره وحشت اینکه مؤلفههای رفتاری اضطراب نیز همانند ترس است جنگ و گریز فراخوانده میشوند؛ اما موضوعی که ،معده بالاخره فرد مبتلا از آن بگریزد یا اجتناب کند یا علیه آن باید پرخاشگری نشان دهد از وضوح کمتری برخوردار بوده و گاهی اوقات حال آنکه اضطراب بر اساس خطر مبهم استوار ،واقعیت یا مبالغه خطر واقعی قرار دارد،مبهم است؛ بنابراین ترس بر پایه .(۱۳۹۶ ،باچر و همکاران)است

۴ عوامل مستعد کننده اختلالات اضطرابی آیا اختلالات اضطرابی ارثی هستند؟ با توجه به مدارک و شواهد معدودی که ۳- برای مثال تخمین زده میشود .تا به امروز به دست آمده میتوان گفت که دست کم بخشی از این اختلال علت موروثی دارد که ۱۵ تا ۲۵ درصد کودکانی که پدر یا مادرشان اگورافوبیا دارند به اگورافوبیا مبتلا میشوند این در حالی است که تنها ۵ باشند اما این مطلب ثابت نمیکند که اگورافوبیا ارثی است زیرا میتوان گفت که ،درصد جمعیت با اگورافوبیا روبه رو می بچه ها از پدر و مرشان می آموزند که اگورافوبیا بشوند.

۵/۷۳

=

O

۶۸

>1

%. LTE1

4G Vo1) L

۱۵:۱۸

1_3784066676 >

۷۰

اختلال های رفتاری و هیجانی

اختلالات در دسته اختلالات اضطرابی قرار DSM-5در (۱۳۹۶)رفتار درونی سازی شده هستند هاردمن و همکاران آگورا فوبیا بسیاری ،میگیرند اختلال اضطراب جدایی لالی سکی انتخابی فوبی خاص فوبی اجتماعی اختلال وحشت زدگی از اختلالات اضطرابی میتوانند در دوران کودکی تظاهر کنند که عبارت انه اختلال اضطراب جدایی اختلال پانیک یا هراس اختلالات اضطرابی به طور شایع در خانواده ها وجود دارد بنابراین اغلب پزشـ در می .اختلال اضطرابی منتشر و فوبیاها خجالت ،دارند اغلب کودکان مبتلا اختلالات اضطرابی یک سری علائم مانند .مضطرب والدین مضطرب ،یابند که کودکان اجتماعی که اعتماد به نفس ملال و افزایش حساسیت به سرزنش یا طرد شدن را تجربه می حداقل یک سوم ،دوری گزینی از کودکان مبتلا به اختلالات اضطرابی دارای معیارهای دو یا اختلال اضطرابی به صورت همزمان میباشند کی و همکاران، ۱۳۸۶).

اضطراب و یا هر دو را در طول زندگی خود تهـ می ،اضطراب و تفاوت بین آنها در عمل تمامی کودکان ترس ،۴ ترس-۲ همه ما ترس را تجربه کرده ایم هنگامی که خطر را تجربه میکنیم دستخـ تغییرات بدنی و هیجانی گوناگون میشویم که .کنند پاسخ ترس را تشکیل میدهند ت چیزی نیست جز یک احساس و هیجان که آنها را در ذهن خود میپرورانیم پـ ترس دارای چهار عنصر است

الف عناصر شناختی انتظار آسیب قریب الوقوع.

خطر به علاوه تغییرات موجود،ب عناصر بدنی واکنش اضطراری بدن به

ظاهر ما.

عناصر هیجانی احساسهای دلهره و وحشت و وحشت زدگی (ج

paration Anxiety Disorder

lective Mutism

ecific Phobia

cial Anxiety Disorde

nic Disorder

goraphobia

ar

اختلالات اضطرابی

|||

O

4G Vo3) %. LTE1د عناصر رفتاری جنگ و گریز

۱۵:۱۹

: Q 1_3784066676)

۷۶

اختلال های رفتاری و هیجانی

ً خانواده های تک والدی خانواده هایی که الگوهای ارتباطی بسیار نزدیک و در هم تنیده ای دارند و نسبت به هم شدیدا در حال تنش هستند یا خانواده هایی که ً خانواده هایی که محیط زندگی شان مملو از استرس است و والدین دائما ،وابسته اند، اند علل دیگر مربوط به .یکی از افراد نزدیکشان را مانند یکی از فرزندان یا پدربزرگ یا مادربزرگ را از دست داده (۲۰۱۹ ،ماش و ولف)کودکان درون گرا یا خجالتی که مستعد این اختلال هستند ً ویژگیهای شخصیتی کودک می شود مثلا برای اختلال اضطراب جدایی روشهای مختلفی توسط پژوهشگران در سالهای اخیر مورد استفاده قرار گرفته است که در زیر به مهمترین آنها اشاره

می شود.

روش تن آرامی یکی از روشهای کاربردی در حوزه درمان اختلالات اضطرابی در کودکان و نوجوانان روش آرمیدگی رایج ترین روش شناخته شده آرمیدگی آموزش آرمیدگی پیش رونده جکوبسون است که به منظور ایجاد یک حالت .است آرامش عضلانی عمیق ابداع شد این روش میتواند برانگیختگی نظام عصبی مرکزی و نظام عصبی خودمختار را کاهش

آرام سازی ،۲۰۰۶ در این دیدگاه)دهد و در نتیجه به حفظ یا ارتقای سلامت روانی و بدنی منجر شود الاندروولد و دانلپ بافت های عضلانی به عنوان یک حالت فیزیولوژیکی است که دقیقه نقطه مقابل تنش بوده و در نتیجه میتواند به عنوان یک درمان منطقی برای افراد مضطرب و پرتنش به کار گرفته شود آرمیدگی تدریجی عضلات تکنیکی است که به صورت با عضلات بالایی سر و گردن شروع میشود و با ًسفت و شل کردن متناوب عضلات بزرگ اجرا میشود این حالت معمولا عضلات پایین تر بدن و پاها و بالعکس به پایان

.(۲۰۱۰ ،لارسون و همکاران)می رسد

رویکرد تعامل والد کودک یکی از رویکردهای به نسبت جدید در سبب شناسی و درمان اختلالات دوران کودکی و از جمله مشکلات اضطرابی که بر نقش والدین تأکید میکند رویکرد تعامل والد کودک است درمان تعامل والد کودک یک برنامه آموزش رفتار والدینی تأیید شده است که در سال ۱۹۷۰ توسط آیبرگ برای کار با والدین و کودکان خردسال ۲ تا ۷ سال مبتلا به اختلال رفتار مخرب پایه ریزی شد

۵/۷۸

1. Lundervold

2. Larson

=

|||

O